

分类号:
密 级:

学校代码: 10412
学号: 202181502004



江西中醫藥大學
Jiangxi University of Chinese Medicine

硕士学位论文

古代盱江医家治疗月经病用药规律与诊治

经验探讨

Experiences of Ancient Xujiang Doctors in Treating
Menstruation Disease

学 位 申 请 人

张楚玥

指 导 教 师 姓 名

胡子毅

专 业 名 称

中医临床基础

申 请 学 位 类 型

学术型学位

论 文 答 辩 日 期

2024 年 5 月 31 日

中国·江西·南昌

2024 年 5 月

中文摘要

目的:

本研究通过对宋代至清代的古代盱江医家及其相关著作进行数据挖掘,探讨其治疗月经病的用药规律与诊治经验,为中医临床治疗月经病提供思路与依据。

方法:

收集从宋代到清代的古代盱江医家的相关著作进行整理分类分析,通过 Excel 建立月经病的医案数据库,对数据进行规范化处理后,运用现代统计学方法如频数统计分析、关联规则分析、聚类分析等方法对数据进行深层次地处理,以探讨古代盱江医家治疗月经病的用药及治法规律。

结果:

1. 数据挖掘结果

(1) 疾病统计

本课题共收集到宋代到清代的古代盱江医家有关月经病的医案 214 则。其中崩漏 82 则,闭经 38 则,痛经 38 则,经间期出血 30 则,月经先期 7 则,月经过多 7 则,经期延长 6 则,月经后期 5 则。

(2) 症状统计

总共有 119 个不同症状,其中频次前 10 的症状依次为:崩漏、腹痛、闭经、痛经、经间期出血、不思饮食、乏力、消瘦、面色萎黄、腹冷。

(3) 药物频次统计

药物总个数为 243 味中药,其中使用频次前 10 位药物依次为当归 131 (61.21%)、川芎 100 (46.73%)、白芍 94 (43.93%)、甘草 68 (31.78%)、香附 64 (29.91%)、肉桂 47 (21.96%)、熟地黄 45 (21.03%)、白术 41 (19.16%)、生地黄 40 (18.69%)、茯苓 36 (16.82%)。药物功效统计使用频率前 5 的依次为:调经止痛、润肠通便、补血活血、祛风止痛、止血药。药物四气统计出现频次前 5 位的分别为:温性、平性、微寒性、寒性、微温性药物。药物五味统计出现频次前 5 位的分别为:辛味、甘味、苦味、酸味、微苦味药物。药物归经统计出现频次前 5 位的分别为:肝经、脾经、心经、肾经、胃经。

(4) 药物关联、聚类分析

将纳入病案中的药物进行中药-中药关联分析,选择支持度 >0.1 ,置信度 >0.6 ,按

支持度从高到低进行排列得出 40 组中药-中药高频组合，关联规则度最高的前 10 组药物分别是：当归-川芎，白芍-当归，川芎-白芍，甘草-当归，香附-当归，甘草-川芎，香附-川芎，香附-白芍，熟地黄-当归，熟地黄-川芎。

对出现频次在前 30 的药物进行层次聚类分析，距离类型设置为欧氏距离，聚类方法设置为类平均法，根据层次聚类结果分析得出 5 组核心药物群分别为第一组：当归、川芎、白芍、香附；第二组：甘草、熟地黄、陈皮、柴胡、白术、茯苓；第三组：肉桂、干姜、牡丹皮、延胡索、吴茱萸、人参、黄芪；第四组：生地黄、黄芩、赤石脂、地榆、阿胶、艾叶；第五组：红花、桃仁、蒲黄、莪术、赤芍、白芷、牛膝。

2. 治疗经验探讨

- (1) 崩漏：养血同时注重补阴；调理气机化血瘀；注重补冲任之虚。
- (2) 闭经：温经通脉，和畅气血；调补冲任通月水。
- (3) 痛经：调气和血使经行顺畅；温经散寒以止痛。
- (4) 月经不调：寒温得当，辨病下药；开郁行气，养血调经。

结论：

1. 古代盱江医家用药以血药为主，气药为辅，以四物汤及八珍散的药组为核心处方进行加减，体现了其治疗月经病时以补血养血为主要治法。

2. 月经病多由外感寒热湿邪、内伤七情、劳逸失调、先后天体质因素等导致气血失和、脏腑受损、冲任失调，且发病症状多与血相关，而参与血液生成及运行多涉及肝、脾、肾三脏，故古代盱江医家治疗月经病以调和气血为主，气机调畅则血液正常运行，血液充足则滋养气的生成，气血旺盛则脏腑、冲任功能正常，血海充盈，月经正常。同时月经病疾病症状复杂，要重视辨病辨证，对症下药。

关键词：数据挖掘；古代盱江医家；月经病；经验

Experiences of Ancient Xujiang Doctors in Treating Menstruation Disease

[Author]:Zhang Chuyue (Clinical Foundations of Traditional Chinese Medicine)

Directed by [Hu Ziyi]

Abstract:

Objective:

This study explores the medication pattern and diagnosis and treatment experience of ancient luijiang physicians and their related writings from the Song Dynasty to the Qing Dynasty through data mining, so as to provide ideas and bases for the clinical treatment of menstrual disorders in traditional Chinese medicine.

Methods:

The relevant writings of the ancient dawn doctors from the Song Dynasty to the Qing Dynasty were collected for sorting and analysing, and the database of medical cases of menstrual diseases was established through Excel. After the data were standardized, modern statistical methods such as frequency statistical analysis, correlation rule analysis, cluster analysis, etc. were applied to the data to process them deeply, in order to explore the rules of the medicines and cures used by the ancient dawn doctors in the treatment of menstrual diseases.

Results:

1.Data mining results

(1) Disease statistics

A total of 214 medical cases about menstrual disorders by ancient dawn healers from the Song Dynasty to the Qing Dynasty were collected. Among them, there were 82 cases of metrorrhagia, 38 cases of amenorrhoea, 38 cases of dysmenorrhoea, 30 cases of intermenstrual haemorrhage, 7 cases of premenstrual period, 7 cases of excessive menstruation, 6 cases of prolonged

menstruation and 5 cases of late menstruation.

(2) Symptom statistics

There were a total of 119 different symptoms, of which the top 10 in frequency were, in order: metrorrhagia, abdominal pain, amenorrhoea, dysmenorrhoea, intermenstrual bleeding, inappetence, fatigue, emaciation, yellowish complexion and abdominal coldness.

(3) Frequency statistics of drugs

The total number of medicines was 243, of which the top 10 medicines were *Angelica sinensis* 131 (61.21%), *Rhizoma Ligustici Chuanxiong* 100 (46.73%), *Paeonia lactiflora* 94 (43.93%), *Glycyrrhiza glabra* 68 (31.78%), *Radix et Rhizoma Scrophulariae* 64 (29.91%), *Cinnamomum Cassiae* 47 (21.96%), *Radix Rehmanniae* 45 (21.03%), *Rhizoma Atractylodis Macrocephalae* 41 (19.16%), *Radix Rehmanniae Praeparata* 40 (18.69%), *Poria* 36 (16.82%). The top 5 drug efficacy statistics in order of frequency were: regulating menstruation and relieving pain, laxative, tonifying blood and activating blood circulation, dispelling wind and relieving pain, and antiemetic. The top 5 in terms of frequency of occurrence of the statistics of the four qi of drugs were: warm, flat, slightly cold, cold, slightly warm drugs. The top 5 statistical occurrences of the five flavours of drugs are: pungent, sweet, bitter, sour, slightly bitter drugs. The top 5 drugs in terms of frequency were: liver meridian, spleen meridian, heart meridian, kidney meridian and stomach meridian.

(4) Drug association and cluster analysis

The drugs included in the cases were subjected to TCM-Chinese medicine association analysis. 40 groups of TCM-Chinese medicine high-frequency combinations were identified by selecting drugs with a support level of >0.1 and a confidence level of >0.6 , and the drugs were ranked according to the level of support in descending order. *Paeonia lactiflora*, *Radix Rehmanniae*

Praeparata - Angelica sinensis, Radix Rehmanniae Praeparata - Ligusticum Chuanxiong.

Hierarchical clustering analysis was performed on the top 30 drugs, with the distance type set to Euclidean distance and the clustering method set to class average method, and the results of the hierarchical clustering results showed that the five core drug groups were: Group 1: angelica sinensis, chuanxiong, bai peony, and xiangsui; Group 2: liquorice, ripe dihuang, Chenpi, chaihu, atractylodes macrocephala, and poria; Group 3: cinnamon, ganzhi, mudanskin, yanhuisuo, wuju, ginseng

2. Discussion on treatment experience

(1) Metrorrhagia: nourishing blood and tonifying yin at the same time; regulating qi and resolving blood stasis; tonifying the deficiency of Chong Ren.

(2) Amenorrhoea: warming the menstruation and opening the veins, harmonising Qi and Blood; regulating and tonifying Chong Ren to promote menstrual flow.

(3) Dysmenorrhoea: regulating Qi and Blood to smooth menstrual flow; warming menstruation and dispersing cold to relieve pain.

(4) Irregular menstruation: appropriate cold and warmth to identify the disease and prescribe medicines; opening up depression to move Qi, nourishing Blood and regulating menstruation.

Conclusion:

1. Ancient practitioners of the dawn river used blood medicines as the mainstay and qi medicines as a supplement, using the Four Substance Tang and the Eight Treasures San group of medicines as the core prescription for addition and subtraction, reflecting the fact that their treatment of menstrual disorders was based on tonifying and nourishing the blood as the mainstay of the treatment.

2. Menstrual diseases are mostly caused by external cold, heat and dampness, internal injuries, seven emotions, labour disorders, and physical factors of successive days, leading to qi and blood disharmony, damage to the internal organs, and imbalance of the flushing period, and the onset of symptoms are mostly related to the blood, which involves the three organs of the liver, the spleen and the kidneys in the generation and operation of the blood, therefore, the treatment of menstrual diseases in the Dawn River medical practitioners to regulate qi and blood as a mainstay, and the regulation of qi will lead to the normal operation of the blood, and the blood will be sufficient to nourish the generation of gas, and the qi and blood will function normally, so the blood sea will be normal, the blood and blood will function normally. If the qi and blood are strong, the internal organs and organs will function normally, the blood will be full, and the menstruation will be normal. At the same time, the symptoms of menstrual diseases are complex, and we should pay attention to the identification of diseases and diagnosis, and prescribe the right medicine.

Keywords: data mining; Xujiang Doctors; menstruation disease; experience

目 录

引言.....	1
历史回顾.....	2
一、中医对月经病的认识.....	2
1 对月经病病名的认识.....	2
2 病因病机.....	2
3 治疗原则.....	3
二、现代医家对月经病的治疗及研究	3
1 现代医家的治疗方法.....	3
2 现代医学的研究进展.....	5
三、小结.....	6
一、古代盱江医家治疗月经病用药规律探讨	7
1 研究目的.....	7
2 研究对象.....	7
2.1 文献来源.....	7
2.2 确定检索词.....	8
2.3 纳入标准.....	8
2.4 排除标准.....	8
3 研究方法.....	9
3.1 数据采集.....	9
3.2 数据处理标准化.....	9
3.3 数据挖掘方法.....	10
4 研究结果.....	10
4.1 疾病统计.....	10
4.2 症状统计.....	11
4.3 中药统计.....	12
5 结果讨论.....	21
5.1 药物频次分析.....	21
5.2 药物四气五味及归经分析.....	24
5.3 基于关联规则的中药规律分析.....	25
5.4 基于组方熵层次聚类分析讨论.....	26
二、古代盱江医家治疗月经病经验探讨	28
1 崩漏.....	28
1.1 病因.....	28
1.2 病机.....	30

1.3 治疗经验.....	31
1.4 经典案例.....	31
2 闭经.....	32
2.1 病因.....	32
2.2 病机.....	35
2.3 治疗经验.....	36
2.4 经典案例.....	37
3 痛经.....	38
3.1 病因.....	38
3.2 病机.....	39
3.3 治疗经验.....	40
3.4 经典案例.....	40
4 月经不调.....	41
4.1 病因.....	41
4.2 病机.....	43
4.3 治疗经验.....	44
4.4 经典案例.....	44
不足与展望.....	46
结论.....	47
参考文献.....	48

引 言

月经病是一种妇科临床常见的疾病，其主要特征表现为月经周期、经期以及经量的异常，或伴随月经周期及绝经前后出现症状。常见的月经病类型繁多，包括但不限于月经先期、月经后期、月经先后不定期、月经过多、月经过少、经期延长、经间期出血、崩漏、闭经、痛经等，以及在经行前后和经断前后可能出现的各类症状^[26]。由于其普遍性和多发性，月经病在妇科病中占据重要地位，被称为妇科病之首。

盱江医学，历经千年，在江西抚州及周边县市一带得以传承与发展。这一医学流派特色鲜明，名医辈出，医著丰富，专科完备，堪称我国地方医学的璀璨明珠，与新安医派、岭南医派、孟河医派等共同构筑了我国地域性学术流派的绚丽图景。盱江流域医家众多，医籍丰富，据考证，自西汉至民国，盱江流域的医家高达 963 人，医籍多达 684 种^[1]。在江西历史十大名医中，盱江医学就占据其中八名，分别是陈自明、危亦林、龚廷贤、龚居中、李梴、喻嘉言、黄宫绣、谢星焕，他们的卓越贡献为盱江医学增添了浓墨重彩的一笔。这些古代盱江医家们，至今仍留下了许多关于月经病治疗的珍贵医籍，特别是陈自明、龚居中、万全等医家，他们都撰写过妇科病的专著，为后人提供了宝贵的医学财富。

通过收集整理宋代至清代的古代盱江医家治疗月经病的医案，利用数据挖掘技术，总结其治疗月经病的临床经验，归纳分析辨治月经病的用药规律及诊治经验，为中医临床治疗月经病提供新思路。

历史回顾

一、中医对月经病的认识

1 对月经病病名的认识

中国古代文献记载关于女性月经病的最初文字见于《黄帝内经》，其中描述了“二阳之病发心脾……女子不月”，以及“月事不以时下”等与月经不调相关的症状。此外，东汉名医张仲景编著的医书《金匮要略》在“妇人杂病脉证并治”章节中，也提到了月经不调的相关论述，并针对其辨证及治疗方法给出了明确的指导。后晋代王叔和在《脉经》中提出“月使不调”、“经水少”、“经一月再来”等月经不调的病证。宋金元时期出现了“月水不调”、“月候不调”等相关病名。明代李时珍于《本草纲目》中言：“月经，经者，常也。女人之经，一月一行，其常也，或先或后或通或塞其病也”首次提出月经之名。《妇科玉尺》中提到：“经贵乎如期，若来时或前或后，或多或少，或月二三至，或数月一至，皆为不调。”说明女性正常生理循环遵循着特定的周期性，同时，其循环的周期天数、出血周期以及流血份量的异常变化均与月经病相关。《女科经纶》亦有记载：“太过不及，皆为不调。其有乍多乍少，断绝不行，崩漏不止，皆由阴阳盛衰所致。”将月经量异常、断经、崩漏归为月经病。

2 病因病机

《济阴纲目》论述：“心脾平和，则经候如常，苟或七情内伤，六淫外侵，饮食失节，起居失宜，脾胃虚损，心火妄动，则月经失调矣。”将来月经失序的原因总结为外界环境的侵袭、情绪的扰动和日常生活饮食的不规律。陈自明在《妇人大全良方》中提到：“妇人月水不调，由风邪乘虚……除此之外病因亦有寒热湿邪侵袭、情志因素、房室所伤、饮食失宜、劳倦过度和体质因素。”他认为月经病病因虽有内、外因之分，但多为内外因相合而为病，且外感、饮食、情绪等病因之间可相互影响。《临证指南医案》中记述：“原其致病之由，有因冲任不能摄血者，有因肝不藏血者，有因脾不统血者，有因热在下焦、迫血妄行者，有因元气大虚，不能收敛其血者，又有瘀血内阻，新血不能归经而下者。”这些记载阐释了脏腑及冲任脉失常引发疾病的原因，并对虚、热、瘀这三个主要病机作了明确揭示。《中医妇科学》则把月经病的成因归纳为外感邪气、内伤七情、饮食不当、劳倦过度、体质因素等，这些影响了脏腑的正常功能，造成气血失

衡，最终间接或直接伤害到冲、任、督、带脉等，导致肾脏与冲任脉、胞宫等功能异常而引发月经病。另外，关于痛经、经期及经期前后出现的各类疾病，其随着月经周期而出现的特性，除了这些病因外，还与经期和经期前后气血变化、血海盈亏等关系密切。

3 治疗原则

在《女科经纶》中，萧慎斋提到：“妇人先病而致经不调者，有月经不调而生诸病者。如先因病而后经不调，当先治病，病去则经自调。若因经不调而后生病，当先调经，经调则病自除。”阐明了治疗月经病重点在于治本以调经，可采取补肾、宁心、扶脾、疏肝、调理气血、调治冲任、养护胞宫等治疗方法。再来，治疗月经病需遵循“急则治标，缓则治本”的原则。例如患者痛经剧烈，应优先考虑缓解疼痛；若经血过多暴下，则应立即止血。待急症得到缓解后，则深究疾病发生的本质原因，以恢复经期正常为治疗目标。此外，月经相关疾患通常是环环相扣、相互作用的，因此，在治疗时要清楚识别主次，专注于主要病因。

二、现代医家对月经病的治疗及研究

1 现代医家的治疗方法

1.1 名家经验

国医大师夏桂成教授^[2]提出月经以阴阳为本，认为经期周而复始的正常循环应该基于阴阳两者间的动态平衡，月经周期的内涵是体内的阴阳周期性消长转化，他通过自身临床经验自创了夏氏月经周期分期分时法，该方法将月经周期划为四期、五期及七期分法，各个分期都有不同的对应时长。四期分法是依据太极阴阳理论，将月经周期分解为经后期、经间期、经前期及行经期四个部分，此分期主要适用于拥有规律月经周期、无明显异常现象的女性。五期分法则是基于五行运动规律与奇数律（7、5、3），将月经周期更细分为行经期、经间排卵期、经后期、经前前半期及经前后半期，更适用于经前期有明显临床症状的女性。七期分法则是将经后期更细致的分为了三期，这种方式能更精确地判断对于阴阳消长转化的变化，适用范围更广，尤其对于周期偏长或闭经的女性，提供了更好的治疗效果。

高月平教授^[3]认为分期论治月经病是顺应自然、平衡阴阳之举，根据发病时所属时期阳偏盛偏衰的区别，结合分期辨治法进行治疗能事半功倍。高教授以保阴煎为主方，

分别从经前期、经间期、经后期三个方面来论述方药加减用法。高教授认为经前期阳长至重，需在滋阴清热基础上顺应阳长趋势，酌加潜阳及清心疏肝理气之品，如钩藤、泽泻等。经间期重阴转阳，故平衡阴阳为用药重点，主张应在滋阴清热基础上，配伍助阳活血、疏通冲任的药物以促进阴阳转化，如赤芍、当归、川芎等。经后初期阴精亏虚愈重，导致虚热程度越甚，因此用药重在逐渐蓄积阴精，在保阴煎基础上加用二至丸，共奏滋阴养血、调经止血之效。

名老中医辛效毅教授^[4]认为治疗月经不调应顺应月经周期，经后期以滋补肾阴、养血清热为主；排卵期以助阳益阴、理气活血、利湿散结为法；经前期以温补肾阳为主；月经期以理气活血为法。同时注重补肾调肝健脾的治疗方法。

名老中医常青教授^[7]认为寒为妇科疾病的大敌，强调在治法上要注重温阳化瘀。治实寒所致月经病症，常教授常用艾叶、桂枝、吴茱萸、肉桂、小茴香、乌药、香附等；治虚寒则常用杜仲、肉苁蓉、鹿角霜、续断、淫羊藿、巴戟天、覆盆子、益智仁等。针对月经异常，常教授倾向使用诸多花卉类药物，主张其质轻主升，药效温和，不仅能有疏肝解郁，调畅气机的功效，同时也避免了损耗气血的不良影响。调经常用玫瑰花、月季花疏肝解郁、活血调经，合欢花解郁安神，槐花凉血止血等。

方晶晶等^[8]认为治疗月经病应用温通法，即使用温阳散寒、通络化痰、活血化瘀类药物用以温补脏腑、散寒化湿、调理气机，也可配伍理气活血类药物，使温补不呆板，祛邪不伤正，适用于治疗病机虚实夹杂的月经病。

陈维爱等^[9]根据患者临床表现，将女性月经周期分为出血期与非出血期来治疗放环后月经不调。出血期以止血为主，用赤芍、藕节、甘草、生蒲黄、生地黄等活血化瘀、凉血止血；非出血期用熟地黄、当归、炙甘草、山药、菟丝子等调和气血、扶脾固肾。最终 78 例患者中治愈 47 例，有效率为 93.6%。

1.2 医派经验

张瑾等^[5]通过分析孟河医派费氏治疗月经病的处方，研究其用药规律以总结临床经验。研究通过数据挖掘结果得出费氏常用药物频次依次为陈皮、白芍和当归，常用药组为陈皮-当归，发现费氏治疗月经病重视调理肝脾冲任，调经不忘固护脾胃，同时善用药性平淡和缓之药，不求速效，用药和缓轻灵。

蔺倩琪等^[6]对云南姚氏妇科流派治疗月经病的经验进行了深入钻研,并总结出在治疗月经病时应“首重肝脾冲任”,优先考虑调理肝脾以及冲任失衡的问题,明确了失衡为治疗上的关键矛盾点,并以健脾疏肝、促进气血流畅和调节冲任的治疗方式为常法,针对具体病症,选用姚氏加减逍遥散以及姚氏新加当归补血汤为基础药方,并根据病情的不同适度增减。

1.3 针灸治疗

阎润茗主任^[10]认为针灸治疗取穴应多以冲、任、督及肝、脾、肾经脉为主,同时注意分清虚实、寒热,针刺手法需补泻分明,特别要注意月经不调患者的针灸治疗时机。

徐占英教授^[11]在处理月经不调等妇科病时,主要运用以神阙穴为中点的十字取穴法,治疗时会分别定位穴位如中脘、下脘、神阙、气海、关元、天枢、大横还包括中极、气冲、子宫、足三里、三阴交、太冲,针对病人的不同病症调整使用的穴位。

王倩教授^[12]依据女性月经周期内身体阴阳及气血的消长转化,并参考中药周期疗法的理论,遵循了“补肾养血、理气活血、调和阴阳”的原则进行辨证选穴,她相信,该治疗法的主要优点是能利用特定穴位的调节双效性,激发正常的气血循环,使得身体内的气血与阴阳得到平衡,并促使肾脏、天癸、冲脉、任脉以及胞宫之间的关系达到和谐状态。

1.4 外治经验

林福平等^[13]通过将 66 名子宫腺肌症导致痛经患者随机均分成对照组与观察组,对照组使用超声治疗系统结合常规护理,观察组予穴位贴敷治疗结合个性化护理,结果显示穴位敷贴治疗结合个性化护理方案临床效果显著。

李趣英^[14]将 86 例肾虚血瘀型子宫内膜异位症痛经患者随机均分为对照组与观察组,对照组予以穴位埋线治疗,观察组在穴位埋线治疗的基础上结合温胞饮加减内服,结果提示温胞饮加减联合穴位埋线治疗有较好疗效。

陈文潇等^[15]选取 96 例寒凝血瘀型痛经患者分成各 48 例的对照组与研究组,对照组予布洛芬缓释片治疗,研究组四逆汤加味联合中药热奄包治疗,结果表明四逆汤加味联合中药热奄包治疗效果较好。

2 现代医学的研究进展

胡盛书等^[16]通过临床试验探明,少腹逐瘀汤或许能够通过降低炎症因子水平、调节 Wnt/ β -连环蛋白信号通路相关指标,以此治愈因寒凝血瘀引起的 EMT 型痛经问题,并缓解病人的临床表现。谢海燕^[17]经临床研究发现少腹逐瘀汤联合米非司酮治疗子宫腺肌病伴痛经寒凝血瘀型的临床效果优于单用米非司酮。曾美英^[18]通过临床研究得出结论加味当归芍药散辅治阴虚血热型月经失调有较好疗效,以及对患者的性激素、月经周期、黄体功能、基础体温起积极影响。莫满芳等^[19]通过临床研究得出逍遥散中药配方颗粒可代替传统中药饮片用于治疗肝郁脾虚型月经不调,且可与传统中药饮片互为补充。唐圆圆^[20]经研究发现加味逍遥散结合激素周期疗法对血清激素水平有调节作用,也可改善月经情况,治疗肝郁血虚型月经失调有较好疗效。赵丽等^[21]经过临床试验发现采用当归芍药散辅以布洛芬对 PD 患者进行治疗,可以通过减少炎症因子的释放来缓解疼痛症状,从而增强治疗效果。

三、小结

中医药治疗月经病在现有研究中展现出广泛的应用及良好的疗效,且拥有独特的优势。月经病往往源于寒湿热邪入侵、心理情志因素、房室所伤、饮食不当、过度劳累以及个人体质的问题等,其致病因素主要包括虚、热、瘀,治疗重点在于调经。临床上把握病因病机,审因论治和辨证论治相结合,同时结合现代医学的治疗,不仅可提高治疗效果,还可推进中医药在月经病治疗中的应用,为以后治疗月经病开辟更多的临床思路。

正文

一、古代盱江医家治疗月经病用药规律探讨

1 研究目的

通过收集整理宋代至清代的古代盱江医家对于月经病相关的古籍文献，运用数据挖掘方法总结并分析其辨治月经病的用药规律，以期为中医临床治疗月经病提供一些理论指导。

2 研究对象

2.1 文献来源

古代盱江医家的范围参考自何晓晖教授等人编撰出版的《盱江医学研究》^[22]和杨卓寅教授编撰出版的《江西杏林人物》^[23]，以及谢强教授等人撰写的《盱江流域及盱江医学地域分布今考》^[24]、《盱江医家医籍及地域分布略考》^[1]、《盱江医家医籍及地域分布略考(续一)》^[25]文章等。

考虑到汉至晋代时期的盱江医家及其著作数量较少且符合数据挖掘纳入标准的方药数量不足，而宋代至清代时期盱江医家及其著作数量较多，故本课题收录的古代盱江医家及其著作以宋、元、明、清四个朝代为准，纳入研究的古代盱江医家共有 18 名，符合纳入标准的现存著作共有 28 本，详细范围参见表 1。

表 1 本课题纳入的古代盱江医家及其著作列表

朝代	医家	著作	朝代	医家	著作
宋代	陈自明	《妇人大全良方》	明代	龚居中	《女科百效全书》
		《管见大全良方》		万全	《万式妇人科》
	洪遵	《洪氏集验方》			《保命歌括》
	黎民寿	《简易方论》			《广嗣纪要》
元代	危亦林	《世医得效方》		吴文炳	《医家赤帙益辨全书》
	萨谦斋	《瑞竹堂经验方》		喻政	《虺后方》
明代	李梴	《医学入门》		易大艮	《易式医按》

龚信	《古今医鉴》	清代	黄宫绣	《本草求真》
龚廷贤	《济世全书》		游斗光	《简便良方》
	《寿世保元》		曾鼎	《妇科指归》
	《万病回春》		谢星焕	《得心集医案》
	《种杏仙方》		喻嘉言	《尚论篇》
	《鲁府禁方》			《尚论后篇》
	《云林神彀》			《寓意草》

2.2 确定检索词

检索词根据《中医妇科学》^[26]、《实用中医妇科学》^[27]等与“月经病”相关的教科书、专著、指南及文献研究，整理并筛选出与此相关的古代中医病名及病证描述。最终确定关键检索词与备选检索词具体如下。

月经先期：经早、经水不及期、经期先行、月经超前；月经后期：经迟、过期经行、间月、二月一至；经间期出血：经漏、漏下、赤白带下；崩漏：崩中、漏下、暴崩、血崩、经漏；闭经：女子不月、血枯、经闭、月水不通、血闭；痛经：月水来腹痛、经来腹痛、经行腹痛、经前腹痛、月水来绕脐疼痛；月经过多：经水过多；月经过少：经水过少；经期延长：月水不断等。

2.3 纳入标准

- (1) 符合月经病相关的中医诊断标准；
- (2) 符合宋代至清代的古代盱江医家标准；
- (3) 原文有完整的方药记录，或仅有方名但可查找到具体药物组成；
- (4) 首诊方药。

2.4 排除标准

- (1) 不符合月经病相关的中医诊断标准；
- (2) 明确出现有“妊娠”、“产前”、“产后”之类词汇的方药，如“产后崩漏”；
- (3) 用量完全相同的重复方药；
- (4) 用法为内服以外的方药。

3 研究方法

3.1 数据采集

依据上述纳排标准对医案进行筛选，选择出符合要求的医案并将其信息如朝代、医家、著作、主治、方名、药物组成等录入到 Excel 表格中，建立月经病医案数据库，对表格中的医案数据标准化处理后将其录入至古今医案云平台。

3.2 数据处理标准化

3.2.1 症状规范

鉴于所涉古籍中症状称谓存在差异，通过姚乃礼教授主编的第二版《中医症状鉴别诊断学》^[28]对其进行标准化整理。如“崩中、漏下、暴崩、血崩、经漏”统一为“崩漏”，“经闭、月水不通、血闭”统一为“闭经”，“月水来腹痛、经来腹痛、经行腹痛”统一为“痛经”，“经水过多”统一为“月经过多”，“经水过少”统一为“月经过少”，“小腹痛、脐下痛”统一为“腹痛”，“肌瘦、骨立”统一为“消瘦”，“饭食进退、吃食减少”统一为“不思饮食”，“带下五色”统一为“五色带”等。

3.2.2 中药名规范

鉴于所涉古籍的中草药名目不统一的情况，通过 2020 年颁布的《中华人民共和国药典》^[29]、《中华本草》^[30]以及《中药学》^[31]进行标准化整理，便于后续数据整理和统计分析。部分中药药名规范见表 2。

表 2 中药药名规范表格

规范前	规范后	规范前	规范后
侧柏、柏叶	侧柏叶	瞿麦穗	瞿麦
椿根皮	椿皮	山梔	梔子
当归头、当归身	当归	芍药、白芍药	白芍
地黄、干地黄	生地黄	熟艾	艾叶
粉草	生甘草	晚蚕砂	蚕砂
干葛	葛根	屋梁上尘	梁上尘
桂心、官桂	肉桂	香附子、制香附	香附

槐子	槐角	小蓟根	小蓟
降真香	降香	芎、芎藭	川芎
苦梗	桔梗	元胡索、玄胡索	延胡索
绵子	棉籽	泽兰叶	泽兰
牡丹、丹皮	牡丹皮	棕榈皮	棕榈

3.3 数据挖掘方法

将 excel 表格中收集到的 214 例月经病的相关医案信息的数据批量导入古今医案云平台。使用该系统的“统计分析”、“层次聚类”、“关联分析”等功能，对病证及方药数据进行频次、属性、聚类和关联等分析，得出证治规律。

4 研究结果

4.1 疾病统计

根据纳入标准和排除标准，共收集到古代盱江医家有关月经病的医案 214 则。其中包含崩漏 82 则，闭经 38 则，痛经 38 则，经间期出血 30 则，月经先期 7 则，月经过多 7 则，经期延长 6 则，月经后期 5 则。具体结果见表 3 及图 1。

表 3 月经病医案疾病频数表

月经病	频次	百分比
崩漏	82	38.32%
闭经	38	17.76%
痛经	38	17.76%
经间期出血	30	14.02%
月经先期	7	3.27%
月经过多	7	3.27%
经期延长	6	2.80%
月经后期	5	2.34%

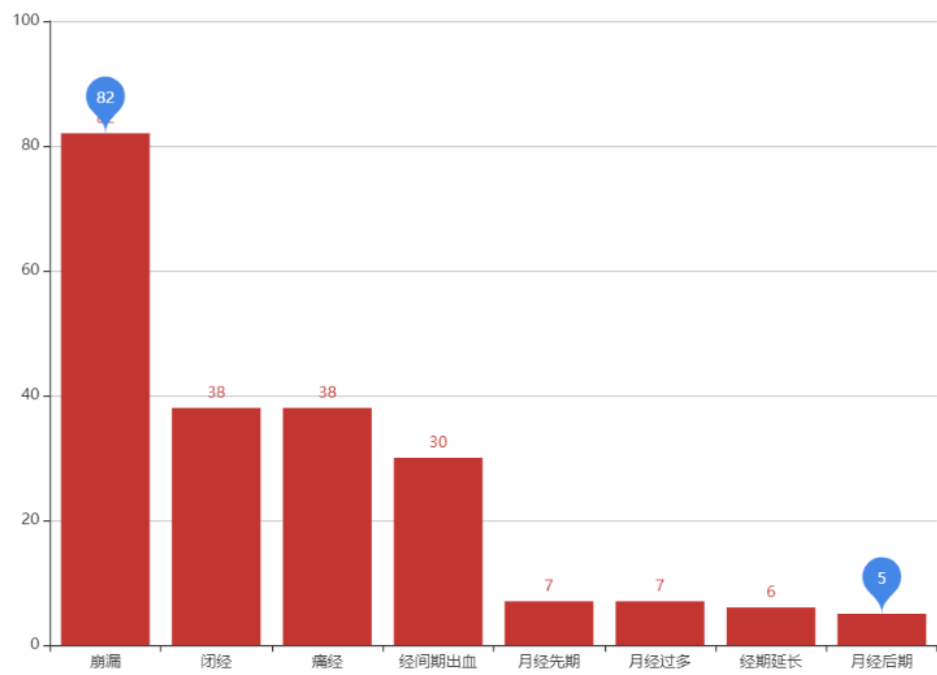


图 1 月经病医案疾病频数图

4.2 症状统计

将纳入病案中的症状进行频次统计，总频次为 585，不同症状有 119 个，按从高到低顺序列出频次 ≥ 3 的症状有 39 个。具体情况见表 4。

表 4 症状频次统计表

排序	症状	频次	百分比	排序	症状	频次	百分比
1	崩漏	82	38.32%	21	胁痛	6	2.80%
2	腹痛	48	22.43%	22	头痛	6	2.80%
3	闭经	38	17.76%	23	发热	6	2.80%
4	痛经	36	16.82%	24	经期延长	6	2.80%
5	经间期出血	31	14.49%	25	月经后期	5	2.34%
6	不思饮食	18	8.41%	26	心烦	5	2.34%
7	乏力	16	7.48%	27	五心烦热	5	2.34%

8	消瘦	15	7.01%	28	咳嗽	5	2.34%
9	面色萎黄	14	6.54%	29	五色带	5	2.34%
10	腹冷	13	6.07%	30	寒热往来	5	2.34%
11	心痛	12	5.61%	31	嗜睡	4	1.87%
12	腹胀	11	5.14%	32	呕吐	4	1.87%
13	经血夹块	11	5.14%	33	心悸	4	1.87%
14	腹中痞块	10	4.67%	34	四肢疼痛	4	1.87%
15	赤白带	10	4.67%	35	身痛	4	1.87%
16	腰痛	8	3.74%	36	口干	4	1.87%
17	头晕	8	3.74%	37	恶心	3	1.40%
18	月经过多	8	3.74%	38	潮热	3	1.40%
19	月经先期	7	3.27%	39	目昏	3	1.40%
20	眼花	7	3.27%				

通过症状频数统计结果,可以看出古代盱江医家治疗月经病的医案中,频次 ≥ 10 的症状有 15 个,分别为:崩漏、腹痛、闭经、痛经、经间期出血、不思饮食、乏力、消瘦、面色萎黄、腹冷、心痛、腹胀、经血夹块、腹中痞块、赤白带。

4.3 中药统计

4.3.1 中药频次统计

将纳入病案中的药物进行用药频次统计分析,总频次为 1854,总个数为 243 味中药。将药物使用频次从高到低排列得出频次前 100 位的药物,具体情况见表 5。

表 5 药物频次统计表

中药	频次	百分比	中药	频次	百分比
当归	131	61.21%	伏龙肝	9	4.21%
川芎	100	46.73%	侧柏叶	9	4.21%
白芍	94	43.93%	苏木	8	3.74%
甘草	68	31.78%	知母	8	3.74%

香附	64	29.91%	防风	8	3.74%
肉桂	47	21.96%	桔梗	8	3.74%
熟地黄	45	21.03%	没药	8	3.74%
白术	41	19.16%	升麻	7	3.27%
生地黄	40	18.69%	栀子	7	3.27%
茯苓	36	16.82%	柏子仁	6	2.80%
黄芩	35	16.36%	紫石英	6	2.80%
干姜	35	16.36%	麝香	6	2.80%
阿胶	33	15.42%	益母草	6	2.80%
艾叶	31	14.49%	血竭	6	2.80%
人参	29	13.55%	山药	6	2.80%
陈皮	29	13.55%	羌活	6	2.80%
牡丹皮	27	12.62%	龟甲	6	2.80%
红花	25	11.68%	细辛	6	2.80%
桃仁	25	11.68%	乌梅	6	2.80%
延胡索	21	9.81%	丁香	6	2.80%
赤石脂	21	9.81%	五灵脂	6	2.80%
白芷	20	9.35%	荆芥	5	2.34%
蒲黄	19	8.88%	泽兰	5	2.34%
莪术	19	8.88%	补骨脂	5	2.34%
黄芪	17	7.94%	乌药	5	2.34%
牛膝	17	7.94%	小蓟	5	2.34%
赤芍	17	7.94%	棕榈	5	2.34%
地榆	16	7.48%	代赭石	5	2.34%
吴茱萸	16	7.48%	乳香	5	2.34%
柴胡	16	7.48%	藁本	5	2.34%
木香	16	7.48%	五味子	5	2.34%
大黄	15	7.01%	石斛	4	1.87%

厚朴	15	7.01%	枳实	4	1.87%
黄柏	15	7.01%	桑寄生	4	1.87%
小茴香	14	6.54%	白薇	4	1.87%
鹿茸	14	6.54%	鳖甲	4	1.87%
龙骨	13	6.07%	刘寄奴	4	1.87%
禹余粮	13	6.07%	肉苁蓉	4	1.87%
续断	13	6.07%	桂枝	4	1.87%
砂仁	13	6.07%	肉豆蔻	3	1.40%
黄连	13	6.07%	茯神	3	1.40%
青皮	13	6.07%	葱白	3	1.40%
牡蛎	12	5.61%	胡椒	3	1.40%
半夏	12	5.61%	干漆	3	1.40%
附子	12	5.61%	朱砂	3	1.40%
枳壳	12	5.61%	杜仲	3	1.40%
三棱	11	5.14%	水蛭	3	1.40%
苍术	11	5.14%	虻虫	3	1.40%
沉香	10	4.67%	椿皮	3	1.40%
乌贼骨	10	4.67%	大枣	3	1.40%

其中使用频次 ≥ 20 次的药物有 22 味,从多到少的排序依次是:当归 131(61.21%)、川芎 100 (46.73%)、白芍 94 (43.93%)、甘草 68 (31.78%)、香附 64 (29.91%)、肉桂 47 (21.96%)、熟地黄 45 (21.03%)、白术 41 (19.16%)、生地黄 40 (18.69%)、茯苓 36 (16.82%)、黄芩 35 (16.36%)、干姜 35 (16.36%)、阿胶 33 (15.42%)、艾叶 31 (14.49%)、人参 29 (13.55%)、陈皮 29 (13.55%)、牡丹皮 27 (12.62%)、红花 25 (11.68%)、桃仁 25 (11.68%)、延胡索 21 (9.81%)、赤石脂 21 (9.81%)、白芷 20 (9.35%)。

4.3.2 中药功效统计

将纳入病案中的药物进行功效统计分析，排名前五的药物功效依次为调经止痛、润肠通便、补血活血、祛风止痛、止血药。具体情况见表 6。

表 6 药物功效统计表

功效	频次	百分比
调经止痛	195	10.32%
润肠通便	168	8.89%
补血活血	131	6.93%
祛风止痛	126	6.67%
止血	117	6.19%
散寒止痛	108	5.72%
活血行气	100	5.29%
平抑肝阳	94	4.98%
柔肝止痛	94	4.98%
养血调经	94	4.98%

4.3.3 中药四气统计

对药物的四气进行统计，其中按照出现频次从高到低排序出前 5 位的分别为温性药物使用频次为 682 次（36.79%），平性药物使用频次为 373 次（20.12%），微寒性药物使用频次为 252（13.59%），寒性药物使用频次为 167 次（9.01%），微温性药物使用频次为 153 次（8.25%）。具体见表 7 及图 2。

表 7 药物四气统计表

四气	频次	百分比
温	682	36.79%
平	373	20.12%
微寒	252	13.59%
寒	167	9.01%

微温	153	8.25%
----	-----	-------

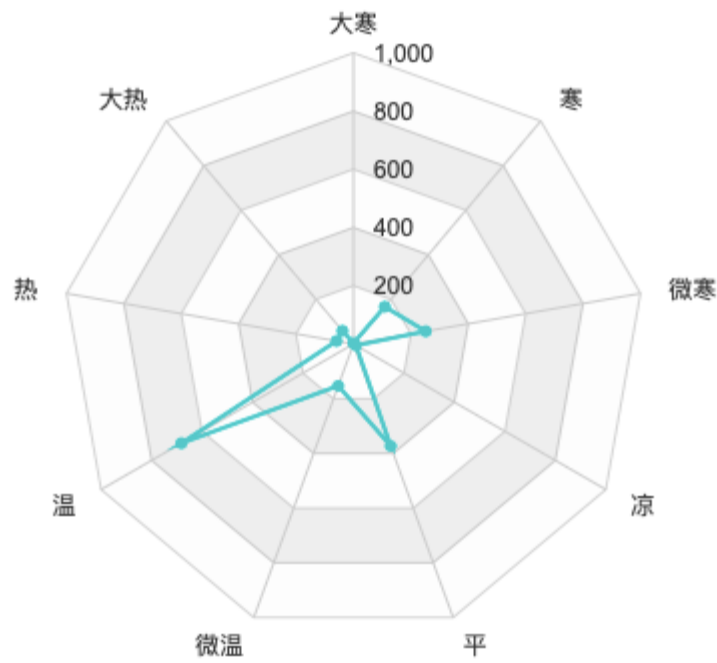


图 2 药物四气雷达图

4.3.4 中药五味统计

对药物的五味进行统计，其中按照出现频次从高到低排序出前 5 位的分别为辛味药物使用频次为 926 次（49.95%），甘味药物使用频次为 747 次（40.29%），苦味药物使用频次为 713 次（38.46%），酸味药物使用频次为 189 次（10.19%），微苦味药物使用频次为 102 次（5.50%）。具体见表 8 及图 3。

表 8 药物五味统计表

五味	频次	百分比
辛	926	49.95%
甘	747	40.29%
苦	713	38.46%
酸	189	10.19%

微苦	102	5.50%
----	-----	-------

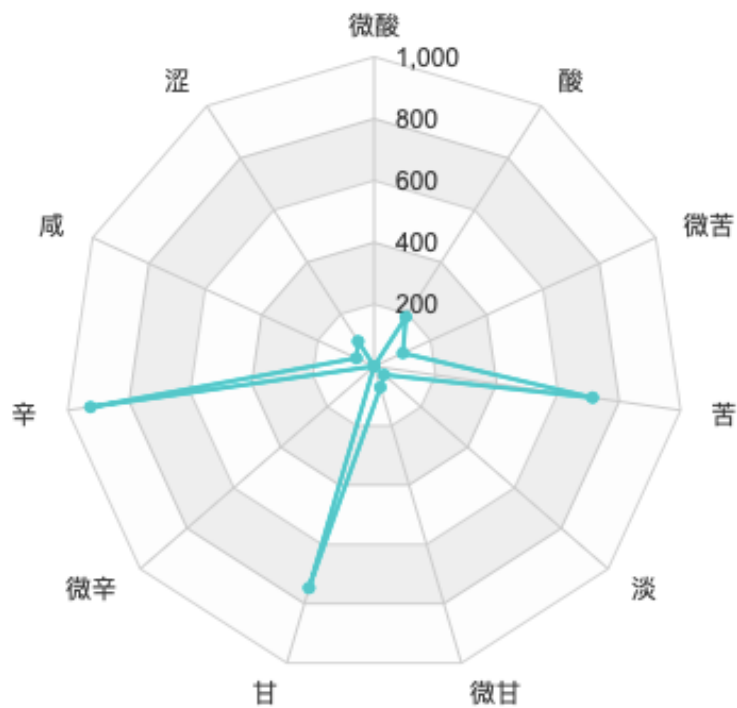


图 3 药物五味雷达图

4.3.5 中药归经统计

对药物的归经进行统计，其中按照出现频次从高到低排序出前 6 位的分别为肝经使用频次为 998 次，占比 53.83%；脾经使用频次为 952 次，占比 51.83%；心经使用频次为 554 次，占比 29.88%；肾经使用频次为 509 次，占比 27.45%；胃经使用频次为 436 次，占比 23.52%；肺经使用频次为 426 次，占比 22.98%。具体见表 9 及图 4。

表 9 药物归经统计表

归经	频次	百分比
肝	998	53.83%
脾	952	51.35%
心	554	29.88%
肾	509	27.45%
胃	436	23.52%

肺	426	22.98%
大肠	209	11.27%
胆	164	8.85%
心包	115	6.20%
三焦	87	4.69%
膀胱	62	3.34%
小肠	9	0.49%

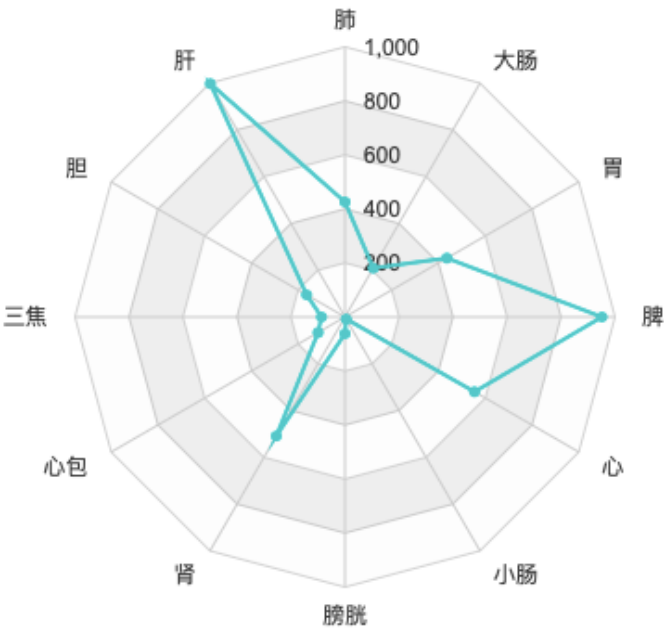


图 4 药物归经雷达图

4.3.6 关联规则统计

将纳入病案中的药物进行中药-中药关联分析，选择支持度>0.1，置信度>0.6，按支持度从高到低进行排列得出 40 组中药-中药高频组合，关联规则度最高的前 10 组药物分别是：当归-川芎，白芍-当归，川芎-白芍，甘草-当归，香附-当归，甘草-川芎，香附-川芎，香附-白芍，熟地黄-当归，熟地黄-川芎。具体见表 10 及图 5。

表 10 药物关联规则统计表

中药	中药	支持度	置信度	提升度	共现度
当归	川芎	0.43	0.7	1.5	92
川芎	当归	0.43	0.92	1.5	92
白芍	当归	0.36	0.82	1.34	77
川芎	白芍	0.33	0.71	1.62	71
白芍	川芎	0.33	0.76	1.63	71
甘草	当归	0.25	0.79	1.29	54
香附	当归	0.23	0.79	1.29	50
甘草	川芎	0.22	0.69	1.48	47
香附	川芎	0.21	0.71	1.52	45
香附	白芍	0.21	0.71	1.62	45
熟地黄	当归	0.2	0.93	1.52	42
熟地黄	川芎	0.18	0.84	1.8	38
白术	当归	0.17	0.88	1.44	36
茯苓	当归	0.16	0.97	1.58	35
肉桂	当归	0.16	0.72	1.18	34
白术	白芍	0.15	0.8	1.82	33
熟地黄	白芍	0.15	0.73	1.66	33
白术	川芎	0.15	0.78	1.67	32
人参	当归	0.14	1.0	1.63	29
白术	甘草	0.14	0.71	2.23	29
生地黄	当归	0.14	0.73	1.19	29
黄芩	当归	0.13	0.8	1.31	28
阿胶	当归	0.13	0.85	1.39	28
阿胶	川芎	0.13	0.85	1.82	28
艾叶	当归	0.13	0.9	1.47	28
茯苓	川芎	0.13	0.78	1.67	28

生地黄	川芎	0.13	0.68	1.46	27
黄芩	白芍	0.12	0.74	1.68	26
黄芩	川芎	0.12	0.74	1.58	26
生地黄	白芍	0.12	0.65	1.48	26
人参	川芎	0.12	0.86	1.84	25
牡丹皮	当归	0.11	0.89	1.45	24
阿胶	白芍	0.11	0.7	1.59	23
艾叶	川芎	0.11	0.74	1.58	23
陈皮	甘草	0.11	0.79	2.49	23
陈皮	当归	0.11	0.79	1.29	23
茯苓	甘草	0.1	0.61	1.92	22
干姜	当归	0.1	0.63	1.03	22
红花	当归	0.1	0.84	1.37	21

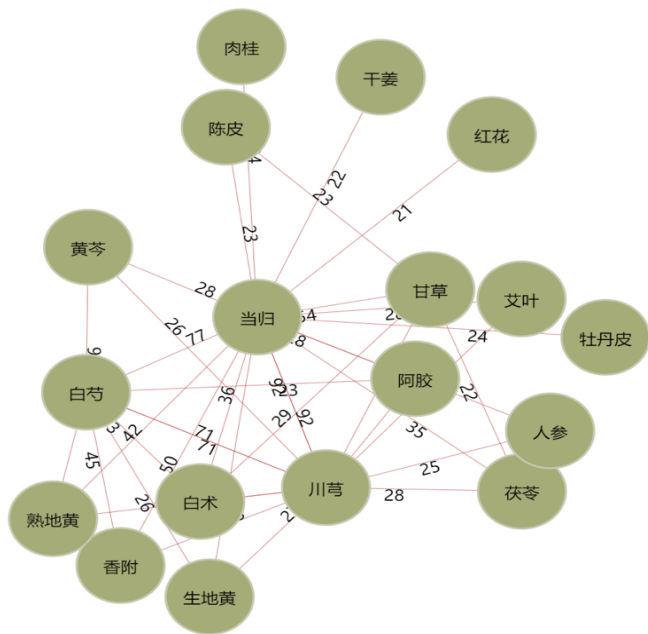


图 5 药物关联规则统计图

4.3.7 聚类分析统计

对使用频次在前 30 的药物进行层次聚类分析，类型设置为欧氏距离和类平均法，根据层次聚类结果得出 5 组核心药物群。具体见图 6。

- 第一组：当归、川芎、白芍、香附；
第二组：甘草、熟地黄、陈皮、柴胡、白术、茯苓；
第三组：肉桂、干姜、牡丹皮、延胡索、吴茱萸、人参、黄芪；
第四组：生地黄、黄芩、赤石脂、地榆、阿胶、艾叶；
第五组：红花、桃仁、蒲黄、莪术、赤芍、白芷、升麻。

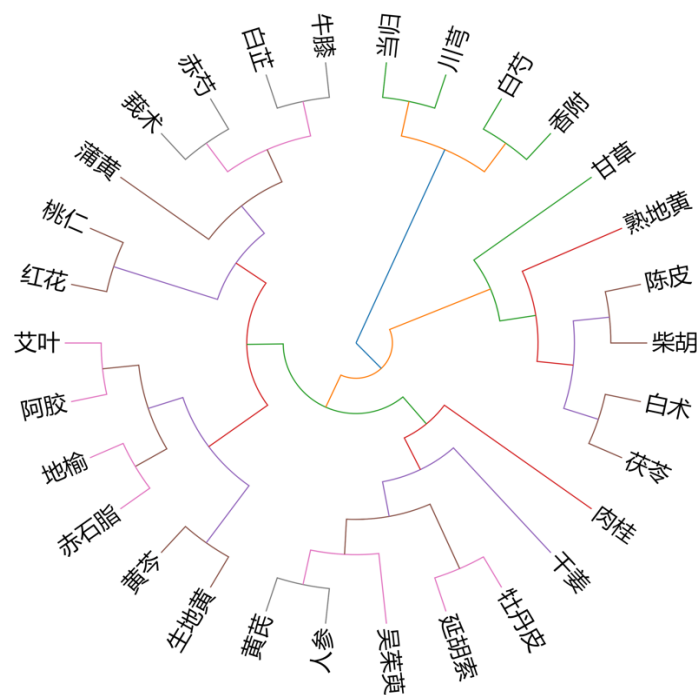


图 6 药物聚类分析统计图

5 结果讨论

5.1 药物频次分析

本研究共选择了 214 首处方，包含中药 243 味，累计频数 1854 次。根据使用频率的不同，使用次数最多的前 10 味中药依次是当归、川芎、白芍、甘草、香附、肉桂、熟地黄、白术、生地黄、茯苓。现对这 10 味药物进行具体分析。

当归：性温，味甘、辛，归肝、心、脾经。《本草纲目》一书中曾提到“当归调血，为女人要药”，阐释了当归是补血调经的要药。《医学衷中参西录》这本著作也有记载：“当归为生血活血之主药，而又能宣通气分，使气血各有所归”，表明当归补血活血、

行气止痛的功效。现代研究表明当归及其有效成分能促进血细胞及血红蛋白的生成^[32]，且有抗血小板聚集的功能。故此，在治疗血虚、血滞、气血不和的月经不调或是因为气血双亏、气滞血瘀所致的痛经问题上，当归是一个理想的选择^[33]。

川芎：本性偏温，味辛且略带苦，其药效作用于肝、胆、心包经。在《本草汇言》中有记述川芎能“上行头目，下调经水，中开郁结”，川芎既能活血又能行气，是调节血气的重要药材，尤擅于治疗血瘀气滞之胸胁、腹部诸痛症。由于川芎作用于肝经，而肝脏是贮存血液的重要器官，肝功能健全能够确保血液充沛，进而滋养和软化身体的经脉。因此，川芎既能疏通血液，消散瘀血，也能补充血液，养护身体健康，展现出其多方面的调节效用。当代研究揭示，川芎及其成分有抗血小板凝集的能力，能够改善微观血流状态，并且对心、肾、肝等组织在缺血情况下的损害具备一定的保护作用^[34]。

白芍：归属于肝、脾二经，呈微寒性，味苦、酸。据《神农本草经》记载此药可主治邪气引起的腹部剧痛，消散血瘀，击碎结块积聚，以及缓解疼痛，强壮元气。《滇南本草》中提到：“收肝气逆痛，调养心肝脾经血，舒经降气，止肝气痛。”因此，白芍具备养血柔肝、缓急止痛的功效，可以治疗月经不调、痛经、崩漏等疾病^[35]。现代研究表明白芍在抗炎、护肝、镇痛和补血等方面的药效，而且其关键成分对子宫有特效作用，因而白芍成为多种女性科病患的治疗药物^[36]。

甘草：性平。《景岳全书》提到：“味至甘，得中和之性，有调补之功，故毒药得之解其毒，刚药得之和其性”。这表明甘草因其味甘，有补养心脾之气、解毒止痛、调合药性的功能。其一，甘草能够滋补脾气，适用于治疗由脾虚气衰引起的月经失调现象；其二，甘草具有匀脏腑之气，同时在药物配合上也能发挥匀和作用；其三，甘草具有缓解作用，既能减轻热性药材的热势，又能补寒性药材的冷邪，还可减缓药物的剧烈效力，防止对人体正气造成伤害。正因为甘草的补、和、缓的特性，它在药物组方中被广泛利用，能在增强体质的同时解毒和协调其他药物的效力^[37]。现代科研揭示，甘草还拥有抗炎症、抗肿瘤、防菌、抵抗病毒、抗氧化和调节免疫等多种功效^[38]。

香附：其性温和，味辛、微苦、微甘。通入肝脾及三焦经。根据《本草纲目》记载，香附能够疏通三焦，疏解各种郁结，对于食物堆积、黏痰滞胀、肿胀、腹部膨胀，以及各种心腹、四肢、头眼、牙齿疼痛等都有显著疗效，乃“气病之总司，女科之主帅也”。

《滇南本草》中也提到其能调治血气，解除忧郁，缓解胸闷，消化不良，还能止吐。因

此，香附能有效调理肝气，促进经血流通，缓解疼痛，是调经止痛的首选药物。现代研究表明，香附及其所含成分对子宫平滑肌具有抑制的作用，且能镇痛，对治疗月经不调、痛经等妇科疾病有显著疗效^[39]。

肉桂：性大热，味辛、甘。归肾、脾、心、肝经。《本草求真》中载明：“大补命门相火，益阳治阴。凡沉寒痼冷、营卫风寒、阳虚自汗、腹中冷痛……因寒因滞而得者，用此治无不效。”肉桂辛香猛烈、本性极热，具有温通经脉、补火助阳之效，并且祛散寒邪，止息疼痛，经常与其他补充气血药材配伍应用，以治疗痛经、闭经和产后腹痛等疾病。如果将肉桂与当归、赤芍等配伍应用，便可行血化瘀、补气去劳、止痛^[40]。据现代研究显示，包含肉桂成分的中草药复方制剂，在预防和治疗原发性痛经方面有明确的治疗效果^[41]。

熟地黄：此乃地黄的炮制加工品，其性质偏温和，味甘，主归于肝与肾两经。《珍珠囊》文献记载，熟地黄对于血虚有显著的补益效用，能促进血液循环，并增强气力。再如《本草从新》所载：“一切肝肾阴亏，虚损百病，为壮水之主药。”熟地黄擅长益精填髓、滋阴补血之效，被广泛认定为补血的要药，经常应用于治疗由阴虚引起的缺血、月经不调、肝肾阴虚等疾病^[42]。

白术：性温，味甘、苦。归属为脾与胃经，性温。《医学启源》记载：“除湿益燥，和中益气。”因此，白术具备健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎等功能。它适用于治疗因脾功能虚弱而导致的饮食下降，腹部膨胀腹泻，痰湿头晕心悸，水肿，自汗，胎动不安等症状，因此被誉为“补脾第一要药”^[43]。白术与其他中药通过配伍运用，常用于治疗各种妇科类疾病。如白术与人参配伍，有健脾益气养血之效；与芍药配伍，有健脾柔肝止痛之效等^[44]。

生地黄：本性寒凉，味甘、苦。归心、肝、肾经。在《神农本草经》记载中提到，生地黄可以修复骨折、内伤、消散淤血，强健筋骨，促进肌肉生长，煮服后能够消散体内的寒气与热毒，以及风湿病症，且未经熟处理的效果更佳。而《珍珠囊》亦提及：“凉血，生血，补肾水真阴。”因此，生地黄具有清营凉血，养阴生津的功效，是清热凉血的首选药物。除此之外，生地黄对于止血也有显著疗效，适用于因内脏火旺导致的出血症状，例如吐血、鼻出血、咳血、衄血、血尿以及崩漏等证。现代研究表明，地黄有止血和促进造血细胞功能的作用^[45]。

茯苓：性质平和，既不寒也不热，味甘、淡，主入心、脾、肾三经。在《神农本草经》记载，茯苓能够舒缓胸部不适、调整气血失调，缓和心烦意乱、惶恐不安、心慌以及胸痛，减缓交感寒热的不舒服，治咳嗽、润喉解渴，利尿通畅。长期服用可以安心养性，滋补精神气，不易感到饥饿，并且有助于增长寿命。《本草衍义》中提到：“行水之功多多，益心脾不可阙也。”因而，茯苓有利水渗湿、健脾安神的效果。现代科研发现，茯苓在利尿、保肝、镇静、免疫调节等诸多方面均有正面作用，它对中枢神经系统、免疫系统和消化系统等都具备良好的保护作用。在药物配伍中，茯苓被广泛利用，并在临床上取得了显著的治疗成效，如用于治疗子宫肌瘤的桂枝茯苓丸就有突出的疗效^[46]。

5.2 药物四气五味及归经分析

中医药学中，药性理论属于中药基本理论的核心内容，其中就涵盖了四气、五味和归经。早在《神农本草经》中便有记载，提及药物分为酸、咸、甘、苦、辛的五种味道以及寒、热、温、凉的四种特性。这段话首次对五味四气做了系统的描述。这所谓的四气，亦即四性，涉及了药材能够带来的寒、热、温、凉效果，并且还包含一种平和性药材，这类药对人体寒热的影响不甚显著，处于两者之间。四气揭示的是药物对于人体阴阳平衡及寒热状态的作用倾向。而五味则是代表了药物补、泻、散、敛等作用性质，最早是在春秋战国时期作为饮食调养理论内容出现的，后经历代医家的不断补充发展，形成了较为完善的五味理论。药物的四气和五味是互相联系的，辛、甘味药就多为温热性，如辛温能散、能行；甘温能补、能缓、能和^[47]；苦、淡味药多有寒凉性，如苦寒能燥、能泄。《本草纲目》记载：“凡药之用，皆以气味为主”，“味有五，气有四”，五味反映的是中药本身的物质属性，而四气是表达它的功能属性^[48]，更加表明了四气与五味之间不可分割的关系。

进行统计分析的药物以温性为主，其次为平性药物，两者合计占比超过总药物的一半以上。温药可以振奋阳气、行气活血，如当归、川芎、白术、人参、黄芪、延胡索等；平药善缓善和，既能缓和药性，又能调节阴阳，如甘草、茯苓、龙骨等。温性和平性药物在古代盱江医家治疗月经病中使用的频次较多，显示出月经病多为虚寒的特点。药物的五味统计则以辛、甘、苦为多。辛能散能行，有行气行血的作用，能使气血通畅，治疗月经病常用的活血化瘀药中有60%的药物性能有辛味^[49]。甘能和能缓，有补虚、缓急止痛的作用。《内经》记载：“辛甘发散为阳”，辛甘并用能使发表散邪的同时补中调和

营卫，补中有散不至于呆滞，故补益方剂中不少以甘味为主而配用辛味药物，如四物汤用川芎。苦能泄能降，亦能燥湿坚阴。故辛、甘、苦三味合用有补益润养、燥湿养阴的作用。

进行统计分析的药物归经以肝、脾、心、肾为主。归经表示了药物对机体作用部位、作用范围，即药效所在，有“定位”的特点。肝主要是储存血液，也是血液的发源地，女性月经的通畅不仅仅与肝内血量的充足有关，肝脏的气机畅通同样不可或缺。在《素问》中提到，人在睡眠期间，血液归宿于肝脏，而王冰在对该文献的解读中指出，肝脏负责储血，而心脏则负责驱动血的运行，在机体活跃期间，血液通过经络系统流动；在休息期间，血液则返回存储于肝脏，其原因在于肝脏是调控血海的主体。肝藏泄有度，发挥正常的疏泄功能，使气血运行无阻。另一方面，脾主统血，它是“气血生化之源”，据《金匱要略编注》记载，“五脏六腑之血，全赖脾气统摄”，因此，如果脾气充沛，则能有效进行摄血。而脾气健旺则生化有源，血海得以充盈，使肝有所藏，肝脾互相协作，以共同维持血液的正常运行^[50]。肾主藏精，为先天之本，且女子天癸发源于肾，肾气盛则天癸至，同时肾也参与人体血液的生成。且肝与肾关系十分紧密，有“肝肾同源”之说，肾精与肝血能够相互促进和转换，且肝肾之阴又相互滋养。月经病的发生主要在于血和气^[51]，与肝、脾、肾最为密切相关，同时女子以血为根本，脾为后天之本，气血生化之源，肝藏血，心主血脉，生成和推动血液运行的功能，故治疗月经病的药物中以归肝、脾、心、肾经为主。

5.3 基于关联规则的中药规律分析

通过关联规则分析，可得到盱江医家治疗月经病中常见的几种药物组合。

从得到的数据统计结果中可以看出，关联频次较高的几味药有当归、川芎、白芍、熟地黄，这四味是四物汤的组成药物。这一药方首次被记载于唐代的《仙授理伤续断秘方》中，并在随后宋代的《太平惠民和剂局方》中提到它主要用于治疗妇科疾病，因此有“妇科第一方”之称。《傅青主女科》一书中记载：“四物汤，乃补血之神品”，且傅青主有云“肝之性最急，宜顺而不宜逆；顺则气安，逆则气动”，血行不畅，调肝以求之。当归、川芎、白芍、熟地黄皆归肝经，且有补血养血之功效，加之治疗月经病需重视调补肝血、调畅肝气，结合数据进行分析，发现古代盱江医家治疗月经病多采用以四物汤为核心的处方进行加减，体现了治疗月经病时需以补血为重的特点。除此之外，人

参、白术、茯苓和甘草等药物也常见于多方配方中，它们组成了四君子汤，有补气健脾的功效。其与四物汤的四味药材合用为八珍散。八珍散源于《瑞竹堂经验方》，有益气补血的功效，善治气血两虚型崩漏、月经不调等妇科疾病。

以下将对上述关联频次高的药物组合进行分析。

当归与川芎：当归主要用于补血活血，调经止痛，对于血虚血瘀有寒性症状的疾病特别适用；而川芎擅长活血行气，特别适于治疗因血瘀气滞导致伴有寒性的各种疼痛症状^[52]；二者组合一补一行，共同作用补血行血功效，并且川芎与当归配伍也可增强其活血的功效。当归-川芎是本课题中出现频次最高的一组药组，同时也是临床常用的活血化瘀药组，这组药对于古籍中的记载可见宋代《太平惠民和剂局方》的“芎归汤”，有补血活血、化瘀止痛的功效，善治崩中即崩漏等腹痛、失血过多类的妇科疾病。

当归与白芍：白芍性凉而滋、补血敛阴，当归-白芍是临床治疗妇科疾病常用药对，其治法以理血行滞、温经散寒、疏肝解郁、补益肝肾、益气养血、调经止痛为主。当归-白芍的药对运用还可见于多个名方，如临床最常用的补血方剂“四物汤”，疏肝健脾常用的“逍遥散”，养血调肝健脾的“当归芍药散”等均是以此两味药配伍为核心组成的，实为补血活血调经的良药^[53]。

川芎与白芍：川芎能活血行气止痛，而白芍养血敛阴、缓急止痛，调和川芎的辛散与白芍的温和收敛，能够使血液流畅而不伤血，而且它们都归肝经，具备促进血液循环、气机通畅并调节肝脏功能的效果。

当归与甘草：甘草行于心、肺、脾、胃四经，具备补益脾气、缓急止痛的功效，并且能够调和各类药物，与当归配伍，能够共同调理气血，也可加强当归的补血功效。当归与甘草配伍常见于治疗月经病中，如当归芍药甘草汤，对于治疗气血不和、肝脾不和、气滞血瘀的月经病有较好疗效^[54]。

当归与香附：香附有行气解郁、调经止痛的功效，常用于治疗肝气郁结的月经不调。与补血活血的当归配伍，可于血中行气，祛滞则通，通则不痛，可治疗有腹胀、腹痛症状的月经病。

5.4 基于组方熵层次聚类分析讨论

将收集到的医案中的中药进行层次聚类，根据结果分析得出 5 组核心药物群。

第一组：当归-川芎-白芍为治疗月经病的常见药物组合，能活血补血、调经止痛，

与香附组合加强行气功效，同时疏肝解郁、补脾益气，适用于治疗气滞血瘀、肝脾失调型月经病。

第二组：柴胡、白术、茯苓、甘草为逍遥散的组成药物，主治肝郁血虚脾弱证有显著疗效。柴胡精于疏肝解郁，调达肝气，且能助益肝脏与血液的协调。白术及茯苓则有利于健脾去湿，使运化有权，保障气血生成过程的正常进行；甘草益气补中，缓急止痛。几味药材配合使用，不仅能调和肝脾、疏肝解郁，而且能养血健脾。陈皮可加强理气健脾功效，同时还能燥湿化痰。熟地黄补血养血，加强对血虚的治疗。

第三组：肉桂、干姜、吴茱萸均为温里药。肉桂入心肝脾肾经，既能散寒止痛，又能温通血脉，为治疗寒凝血瘀证之要药；干姜能温中散寒，有效缓解脘腹冷痛；而吴茱萸的特点在于驱寒止痛，也能疏肝解郁，是治疗肝寒气滞之要药。人参和黄芪均为补气佳品。人参归脾肺经，善于大补元气；黄芪则在益气补虚方面更胜一筹；两药配伍，相须为用，构成甘温补气的重要组合，极适宜于治疗气虚诸症。牡丹皮、延胡索皆可活血祛瘀止痛。此组药物配伍，可治疗寒凝血虚血瘀型月经病。

第四组：阿胶养阴润燥，为补血之上品，止血之良药。艾叶能够驱散寒气缓解疼痛，并且暖通血脉以止血。阿胶艾叶配伍，阿胶为气中之阴，艾叶为血中之阳，有升有降，和合以调气养血，止血固脱。阿胶与艾叶同为胶艾汤的组成药材，主治虚寒性的崩漏或妊娠下血。生地黄、黄芩、地榆、赤石脂皆有止血功效。

第五组：红花主要用以活血通经，还具备消散瘀伤和缓解疼痛的效果，桃仁同样也有活血祛瘀的作用，这两种药材经常一同搭配应用，比如在桃红四物汤中，它们能有效地打通瘀血，促进血液的畅通，专门用于治疗由瘀血引起的经痛。莪术配伍助其活血化瘀之功。蒲黄、赤芍有补血止血、化瘀止痛的功效，可用于治疗崩漏及月经不调。牛膝能逐瘀通经，常用于治疗闭经、痛经。白芷亦有止痛功效。本组药物主要发挥活血化瘀止痛的功效，善治瘀血阻滞型月经病。

二、古代盱江医家治疗月经病经验探讨

月经病是一种妇科临床常见的疾病，其主要特征表现为月经周期、经期以及经量的异常，或伴随月经周期及绝经前后出现显著症状。常见的月经病类型繁多，包括但不限于月经先期、月经后期、月经先后不定期、月经过多、月经过少、经期延长、经间期出血、崩漏、闭经、痛经等，以及在经行前后和经断前后可能出现的各类症状^[26]。由于其普遍性和多发性，月经病在妇科病中占据重要地位，甚至被誉为妇科病之首。

本课题对古代盱江医家有关月经病的医案进行数据挖掘，根据得到的相关频次数据，本篇将着重从崩漏、闭经、痛经、月经不调四个类型的月经病进行探讨。

1 崩漏

所谓崩漏，是指经血非时暴下不止或淋漓不尽，突发性大量出血为“崩中”，或是血液缓缓持续性排出难以止住的为“漏下”，这两种症状往往会互相转换，因此统称之为崩漏。本病属于妇科常见病，也是疑难急重病证，故古代盱江医家擅治妇科病者对此论述颇多。南宋医家陈自明在《妇人大全良方》一书中，将崩漏归属在调经门下进行论述，在首章开篇载明“凡医妇人，必先调经，故以为初”，陈氏提出，若因为先患疾病后导致月经不调，则应先行医治先发的疾病，待疾病解除后，月经自然恢复正常；反之，若是因月经不调而导致生病，则需优先调经，一旦月经畅通，相应的疾病也会随之痊愈^[55]。

导致崩漏的原因有很多，如情志失调、房事不节、冲任虚损、脏腑虚损等，可概括为热、虚、瘀三个方面^[56]，主要与肝、肾、脾三脏相关。主要发病机理是劳伤血气，脏腑受损，并致冲脉和任脉失去制约经血之能，使得气血产生紊乱，不再遵循正常路经运行，最终造成经血非时而下，出现崩漏。

1.1 病因

1.1.1 热

陈自明认为崩漏的发生原因是“此由阴阳搏，为热所乘”，明代医家李梴也认为“阴搏阳，谓之崩。言属热者多也”。机体内部原本有热，伴随阴阳相搏，导致热伤及冲任二脉，最后血崩。《素问·阴阳别论》也有记载道：“阴虚阳搏为之崩”。女子以肝为根本，肝主管储存血液，体阴而用阳，若是阴血不充足，容易导致阳气过旺，引起阳亢。

怒动肝火，或因肝气郁结，积聚久了转化为内热，隐匿于冲任，便会冲破血液使其失去正常轨迹，引发崩漏。另外，体内的湿气和浊气沉降，结合而生热，直接侵入胞宫、胞脉，湿热阻扰，引起冲任脉的功能失稳，同样会导致崩漏。或者因为饮食习惯无度，过量摄入刺激性强的辛辣食物，助长阳气，热动冲任，迫使血液异常流动。

1.1.2 虚

1.1.2.1 肾虚

明代医家万全在《万氏妇人科》一书的“调经章”中论述了崩漏，他认为冲任损伤是导致崩漏的主要病因。房室行事失宜，乃损伤冲任之主因，“女未及二七天癸之期，而男子强与之合”，“于月事适来未断之时，而男子纵欲不已”，由于冲任受损，进而使得肝脏失去对血液的调控能力，从而诱发崩漏等疾患的出现。李梴亦在《医学入门》中提及“虚多房劳”。或者由于先天肾气不足，天癸初至，冲任未盛，失去制约经血之力，因而发生崩漏。冲任二脉若是无力衰弱，天癸日益干涸，肾中阳气衰微，阴液亏缺，命火失序躁动，会造成阴阳不协调而引发崩漏现象。

1.1.2.2 脾虚

脾脏因为先天衰弱未能正常运化，或是由于忧愁多虑、身心过劳或者饮食不规律所造成的脾虚。脾主要负责统血，当脾气充沛时，血液得到妥善的控制。相反，如果功能出现障碍，掌控力下降，就无法有效维持血液在经络中的稳定，从而导致异常出血以致崩漏。万氏认为，崩中的病因是中气虚伴体内积热而引起，而漏下由崩久而化乃中气下陷，下元不固所致。脾气可输布水谷精微，而水谷精微能够化生成为血液，若中气虚陷，水谷失于输布，则血无所依从而下血妄行。

1.1.3 瘀

瘀血瘀阻于内，则新血不能化生，旧血不去，新血难安，发为崩漏。气机调畅为血行之根本，而肝主疏泄，调畅气机，若情志不舒，肝气郁结，气滞则血脉瘀滞，而瘀血停于内，血运不畅又可加重气滞，两者互为因果。或气虚阳虚，气虚则气滞，气滞则血停，因而致瘀。或热扰冲任，迫血离经外溢，积聚成瘀。或贪嗜凉饮，寒湿凝结，冷邪在体内积聚而导致血瘀。或因冲任胞宫受损，影响气血运行，则内生瘀滞。《诸病源候论》中提到：“内有瘀血，故时崩时止，淋漓不断。”这进一步阐释了血瘀为导致经血过多的关键原因，而活血化瘀则是治疗该病症的核心疗法。

1.2 病机

1.2.1 阴虚阳搏，热扰冲任

《黄帝内经·素问》中的“阴阳别论”章节阐释了“崩”形成的生理过程即为“阴虚阳搏”。陈自明阐释了这个理论，他认为阳气过度旺盛引起的热病侵袭妇女的任冲二脉是导致妇女出现崩漏的原因，认为当血液受到热邪的影响就会四散流溢，就像酷暑使地表温度升高导致河水沸腾溢出一样，当内热过度使得冲任二脉受损，血液失去正常轨迹，出现异常流血，从而形成崩漏。《景岳全书》中“妇人规”章节明确表述：“故凡阳搏必属阴虚，络伤必致血溢。”

1.2.2 脏腑损伤，冲任虚损

《诸病源候论》中提出，所谓的“崩中”、“漏下”现象，其原因在于内脏的损害，导致冲脉与任脉出现虚损，从而无法控制经血。文中阐释：“崩中者，脏腑伤损，冲脉任脉血气俱虚故也。”清代医家谢星焕亦在《得心集医案》中记载：“妇人久崩……必是冲脉损伤。”陈自明主张，由于冲任两脉气虚导致月经血液无法被制约，从而出现不止的现象。各类因素引发的冲任虚弱，以及气虚失于摄血，血液溢出脉络是导致崩漏的关键。他还提到，风为万物之动力，当冲任二脉处于虚弱状态时，若受风邪之害，则会引起崩中现象爆发。

1.2.3 脏腑功能紊乱

宋代医家进行了崩漏病理机制的研究，结果涉及肝、脾、肾三脏。严用和在《严氏济生方》中分析崩漏时提出肝不藏血致崩的机理，他认为由于肝脏为血液所居之地，情绪波动或劳累过度容易造成损伤，所以“肝不能藏血于宫，宫不能传血于海，所以崩中漏下。”另《傅青主女科》中对此情况有着类似的解读：“夫肝主藏血，气结而血亦结，何以反至崩漏？”李东垣在其著作《兰室秘藏》中分析了多数崩漏案例起源于脾胃的虚弱损伤；明朝薛己也在《女科撮要》中明确了经血不止是由于“脾胃虚损，不能摄血归源”。《兰室秘藏》中又提及：“妇人血崩，是肾水阴虚，不能镇守胞络相火，故血走而崩。”

1.2.4 瘀血阻滞

陈自明在其著作《妇人大全良方》里提出：“血崩乃经脉错乱，不循故道……便有结瘀之血，凝成窠臼”。他主张，血液因未沿既定的路径行走导致的崩漏症状，如不

赶快治疗，离经之血将形成血瘀和块块相连的窠臼，从而使得情况恶化。

1.3 治疗经验

1.3.1 养血同时注重补阴

崩漏一症伤血耗阴，病机复杂。或气虚夹瘀，或瘀久化热，或热泄气伤，最终互为因果，虚实夹杂，导致阴血不足。《妇人大全良方》中阐释“夫妇人崩中者，由脏腑伤损冲脉、任脉，血气俱虚故也”。也有医家表示这种情况是因为阴阳交错失调，遭受热邪的侵袭，冲击并损害了冲任二脉。因此，古代盱江医家治疗崩漏的各方剂中，均注重养血的同时补阴，以制阴阳相搏之热，而防血耗阴伤，内热扰动，加重病情。如陈氏善用小蓐汤、阿茄堕丸。小蓐汤中的小蓐与生地黄都有凉血止血功效；阿茄堕丸中的郁金、茜根、石榴皮皆能凉血收涩。结合数据挖掘得出的药物配伍来看，黄芩+当归、阿胶+当归、黄芩+地榆等，都是养血滋阴的药组。

1.3.2 调理气机化血瘀

崩漏多因气滞而成瘀。陈自明善用琥珀散与独圣散治疗崩漏，在琥珀散中引张声道的医论进行说明，“有积瘀之血，凝成窠臼；更以药涩住，转见增剧”，并提出治疗上宜先用五积散配合醋进行熬制，先服一两次，接着用灵脂散和调整气机的药物，清除旧血促进新血生成，如此自可逐步恢复健康。危亦林认为血易与气搏，善用香附理气治妇人崩漏，且屡见奇效。故理气化瘀法为古代盱江医家治疗崩漏的经验之一，即使虚证，也宜兼以化瘀行滞，以使营畅隧通，气血归经。

1.3.3 注重补冲任之虚

在其著作《万氏妇人科》内讨论女性月事相关病症的诊治方法时，万全强调了“虚则补之”的原则，主张针对崩漏的医治应以加味补中益气汤配鹿角霜丸为主^[57]。陈自明认为冲任气虚是崩漏的重要病机，补益冲任为固经之本，若冲任受损，则无权制约而致崩中漏下，治疗多用煮附丸、补药丸子、如圣无比散。李梴亦认为崩漏损伤冲任，气血俱虚，宜补。结合数据挖掘得出的高频药物多为当归、阿胶、鹿茸等补虚药，以及人参、黄芪益气固冲以治崩漏。

1.4 经典案例

医案：刘某，女，月经淋漓不尽半月余。自诉既往常有月经不规律，最近因工作调动压力大，半月前自月经来潮后一直淋漓不尽，经量较少，色淡，人神疲乏力，偶有气

短，四肢困倦。舌淡红、苔薄白，脉沉细。方用补中益气汤加减。黄芪 15g、人参 15g、白术 10g、当归 10g、白芍 10g、陈皮 6g、升麻 6g、柴胡 12g、炙甘草 12g、生姜 3 片、大枣 5 枚。7 剂，水煎服，日一剂。二诊症状好转，兼服归脾汤，后痊愈。

按语：患者脾脏虚损，气血不足，故气短，神疲乏力，四肢困倦。脾气可输布水谷精微而化生血液，若脾脏亏损导致中气虚陷，水谷失于输布，则血无所依从而下血妄行。故患者月经淋漓不尽，且量少、色淡。“虚则补之”治宜补气益脾。方为补中益气汤加减。方中黄芪、人参配伍补中益气，升阳固表；当归、白芍补气养血；白术、炙甘草，补气健脾；陈皮理气和胃；升麻、柴胡升阳举陷。二诊后兼服归脾汤以益气补血，健脾养血。

2 闭经

闭经是妇科领域常见的病证，其主要特征为无月经或月经的终止。根据个体既往月经状况的不同，闭经被为两类：一种是原发性闭经，常见于未满 14 岁且性征还未成熟的女性，或是年满 16 岁而性征已成熟但仍未经历过月经的情形；另一种是继发性闭经，即在月经正常的情况下突然无故中断超过六个月或超过三个正常周期。其中，继发性闭经在闭经的总体发病率中占据了较大比例。

引发闭经的原因极多，包括外感邪气、内伤七情、饮食劳倦、房劳多产、体质因素等。此外，如瘀血、痰饮停滞不去，可能会直接或间接对冲任二脉、子宫以及胞脉胞络等造成影响，变成病因进而引起闭经。

2.1 病因

2.1.1 外感邪气

2.1.1.1 风寒邪气

寒为阴邪，易损害阳气，且寒性倾向于凝聚并收引，导致气血凝结，造成循环不畅。

《诸病源候论》中有云，寒风损及脉络之血，血液在温暖时流通无阻，在遇冷时则凝滞不前，如若受到寒气束缚，血液在体内凝结，斯月事难以顺畅。因此，女性在经期、产后、长期疾病导致身体虚弱、不慎接触寒风、或在冰冷气候下冒雨行走时，极易因寒气顺势侵入，侵扰妇女子宫之处，损及冲任二脉，与血液交结，令血液结块气滞，进而引致经路不畅，以致闭经。

2.1.1.2 火热邪气

阳邪之热易损及体内阴液。若暴露于过度炎热的环境，抑或摄入过量辛辣刺激、温热性质的食物，会导致津液遭到热炙，损伤气血，结果可能出现闭经。在《黄帝素问宣明论方》一书中，刘完素曾阐释：“妇人月水……其不来，则风热伤于经血，故血在内不通；或内受邪热……”说明若经停不来，则多因燥热之气侵犯经血，造成血液内部停滞不畅，或因体内感受热邪。因此，火热之邪是诱发闭经状况的原因之一。

2.1.2 内伤七情

七情如喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等情志变化，若程度过剧则可能干扰脏腑机能和气血运行。古往今来的中医学者普遍认同，女性相较男性更易因情绪波动而受损害，因此，情绪失调也是导致女性停经的主要原因之一。《本草衍义》中曾指出，因忧愁与过多思虑引起的停经现象不鲜见，文中描述“积想在心，思虑过当……女则月水先闭”，原因在于忧愁和过度思虑伤及心脏，心脏一旦受损，血液运行不畅，继而引发面色无华和月经中断。《妇人大全良方》和《万氏妇人科》等医学典籍也记录了情绪失衡引发停经的案例。

2.1.3 痰湿瘀血

2.1.3.1 痰湿

人体内的液体代谢出现故障，导致痰湿形成。这种情况是因为肺、脾、肾等脏的气化功能失常，影响了体内津液的正常分布和排出过程，进而引发津液不正常积聚转变为痰湿。李梴于《医学入门》的“妇人门”篇中记载到“湿痰粘住血海地位经闭者”，说明痰湿具有粘稠、浑浊的特性，容易沉积在下部和冲任之处，流动于胞络脏腑之间，或在某些情况下会与瘀血结合，引起闭经。

2.1.3.2 瘀血

瘀血不仅是一种病理现象，也是一种致病因素。引发瘀血的缘由众多，例如受寒导致的凝滞，气流不畅，劳累过度或休息过度等因素。女子月经以血为物质基础，由于血淤容易凝结、堆积、浓稠并粘滞，故而常在冲任二脉，以及子宫和胞衣络脉处造成阻塞。故瘀血也是造成闭经的重要病因之一。

2.1.4 体质因素

4.1.4.1 先天不足

女子先天禀赋不足也是造成闭经的原因之一。室女患闭经之症，系由肾气虚弱，天

癸亏缺，加之肝脏血液亏虚，经血无力生化，冲任二脉流通不畅。或因女性性器官发育欠佳或异常，月经无法顺利来临，或是经血排出受阻。在《广嗣纪要》一籍中，万全记载有“五不宜”之说，即螺、纹、鼓、角、脉，皆是指代女性性器官天生发育缺陷或异常所引发的经闭现象。

2.1.4.2 后天失养

《万氏妇人科》中论述：“脂痰凝塞者……则血气和畅，经水应期。惟彼肥硕者，膏脂充满……血海之波不流。”说明女性若肠胃畅顺，不受阻碍，经脉流转无滞，则气血调和，生理周期准确无误；体态丰满的女性，脂肪过多使得气机闭塞，产生的痰液阻滞无法排出，血液循环不畅，因此出现闭经症状。揭示了后天不同体质导致的疾病发生机理各不相同。体格丰腴的女性，过多的体脂和痰液导致血液循环受阻，进而造成月经不来；形体消瘦，多热多郁，以及血量不足气虚的女性，同样容易出现月经闭塞的情况。故妇人后天的形体的胖瘦，也是导致闭经的一个原因。

2.1.5 其他因素

2.1.5.1 饮食失调

滥食暴饮或长期饥饿，均可能损伤人体的脾胃功能。这样一来，会阻碍气血的正常生化作用，使得滋养生命的后天之精无法累积，无法维持先天之精的活力。脾胃虚弱，血液生成不足，女性的经血量减少，从而可能出现月经停止的症状。食用过多的油腻、甜腥、味道浓烈食物会妨碍脾胃运化功能使痰湿在内部生成并聚集于下身，引发经闭。吃过多的过冷或过热食物也会损伤脾胃，导致食物的摄取和运化能力下降，气血生成来源不足，无法支撑月经的正常来潮，引起闭经。《妇人大全良方》中描述，女性月经不畅常是由贪食酸咸之品开始，逐渐使得血脉变得干涸，转变为消耗性疾病。如果在经期饮食失当，如误食过热食物、生冷或在房事之后，可能会诱发此类疾病。而不卫生的饮食也可能使人体寄生各种寄生虫，进而造成血虚经闭。

2.1.5.2 劳逸失度

《诸病源候论》曰：“劳伤过度，血气枯竭于内也。”女性在经期劳累搬重物，或者过度劳顿，又或是提早从事体力劳动，都可能导致气血受损。一旦气弱，则缺乏推动血液流动的能力，进而造成血液循环不畅顺，甚至血液瘀滞转化为淤血，这会干扰子宫、冲任的正常功能，最终可能表现为闭经。陈自明认为劳力则伤脾，劳神则伤心，房劳则

伤肾，若心脾肾和，气与血得正常运行，所以其将闭经的致病因素亦归结为劳伤。

2.1.5.3 房室失常

《陈素庵妇科补解》一书载明：“女子多合，则精耗而肾亏……而经血自闭。”女性频繁交合，导致肾精亏耗，肾功能衰退，引发心火过度活跃，同时会损害肺部的功能，进而阻断生命化生之根本，使月经停止流动。《万氏妇人科》也相似指出：“欲动而不能得遂，憾愤而不能得伸。”故房事过度或缺少，亦可导致闭经。

2.2 病机

2.2.1 脏腑功能失调

2.2.1.1 肾

肾脏在月经的生成及其调控过程中起着核心作用。肾储藏精元，并且掌管生殖能力，是生命精气的根源，也是冲脉和任脉的基础。如果先天肾气储备不充，命门之水尚未来临或来临延缓，那么冲脉将不充盈，任脉也不畅通。此外，经历过多次生育或流产、房事过度等情况，都会导致血液流失而肾精耗损。肾气受损，肝脏失去滋养，冲脉和任脉均显得虚弱，阴阳二气失去平衡，这些都可能是月经不再的原因。《陈素庵妇科补解》中提出，女子超过二十岁未经期的一个原因是父母遗传给的精血基础不够充裕，天赋的不足导致血气和津液减少，经血因干涸而不流通。

2.2.1.2 肝

肝脏是储藏和调节血液的主要器官，当人体本身血量不足，或是血液生成不够，抑或是失血量较大，或者是由于肾脏的精气不足以滋补血液，亦或是体内火气过旺使得肝血悄然消耗，都可能引发肝脏中的血量缺乏，进而引起血海枯竭，最终表现为闭经。肝脏负责调畅气机，顺畅则喜，郁结则恶。长期压抑情绪或因激怒导致的伤害会令肝脏失去顺畅机能，进而不能妥善疏泄，使得肝气滞塞，气血流通受阻，冲任二脉发生阻碍，终至月经停止。

2.2.1.3 脾

脾负责转化，将水谷中的细微精华转化为生命所需的气和血，滋润身体各处。一旦脾胃功能本就不足，又或者饮食无度，导致脾胃遭到损害，亦或是心力交瘁，思却劳形，导致脾失其正常功能，转化不畅，从而气血生成不足，最终可能导致闭经。

2.2.1.4 心

心负责血液的温煦和循环推进。同时，它还掌管着人的精神状态和思维正常活动。如果长时间精神劳累或者疾病消耗，可能会对心脏造成损害，导致心阴消耗，气血供给不足。若心气不足，影响其向下贯通的功能，可能会引起冲任二脉的功能紊乱，血海无法充盈，导致月经少或闭经等出现。

2.2.2 气血津液失调

2.2.2.1 气血失调

体质虚弱，可能因劳累过度、长期疾病或重病导致体内元气大量耗损，气血双亏使得无法有效推进血液循环，导致血脉流转不顺畅，气滞血瘀最终导致闭经。情绪失调，剧烈怒火损害肝脏，过度忧虑伤害脾脏，导致气机阻滞，阻挠了血液正常流动，导致冲任脉道阻滞不畅，引起闭经。故气虚、气滞可以导致闭经。危亦林亦阐述，闭经的情况往往与气血不调引起的瘀血有关联，由于气的作用是指挥血液运行，如果气的运行发生紊乱，将无法推动血液的循环和调节，进而造成血液流动不顺畅，出现瘀血，堵塞胞宫，从而引起闭经。

2.2.2.2 津液失调

《诸病源候论》中记载：人体依靠水谷转化成的精华，化生为血液和津液，这些液体在体内经络之中循环流动。若人体因过劳而损伤，阳气亏虚，导致血气衰减，津液会失去调节而外泄，表现为出汗过多。如果虚汗不断，便会出现喘气急促，身体消瘦弱不胜衣。此外，还可能引起血液空虚，月经不畅，甚至严重时月经完全停止。这段话体现了津血同源的理论，指出呕吐、唾液分泌过多、腹泻、大量出汗等体液流失严重，可能会造成津亏血虚，致使月经分泌减少，直至经期停止。

2.2.3 冲任受损

先天禀赋不足，后天化源匮乏，长期患病导致养分流失，致使脾和肾功能衰弱，精与血耗损严重，这些都可能引起冲任不足。若冲脉和任脉得不到充分的滋养，则会造成血海、胞宫空虚，进而引起经闭。而情绪抑郁不畅，肝脏的气机不顺畅，这也会阻碍冲脉和任脉的功能，导致闭经。

2.3 治疗经验

2.3.1 温经通脉，和畅气血

当血液受到寒邪侵袭，会导致凝固现象。寒邪常乘人体虚弱之际侵入冲任，造成冲

任瘀滞，阻碍气血正常运行，使血海无法如期充盈，最终导致月水不通。李梴于《医学入门》中记载：“风寒入内，以致凝涩者，小温经汤。”陈自明常用肉桂以发散风寒、温通经脉，并配伍熟地黄、当归、牛膝等药，目的在于补血活血，使活血化瘀而不伤血。

妇女因为天性沉郁或是过于愤慨，引起气血不畅，血液凝滞在冲脉和任脉之中，导致经血阻滞。危亦林在诊治女性经血不畅时常选用当归、红花、桃仁、牛膝。陈自明常用牡丹皮、当归、桃仁、赤芍药等活血通络、疏肝行气，配水蛭、桃仁、三棱、穿山甲、莪术等破瘀通络消积之药^[58]。闭经病无论叙事，治疗均需注重气血，只有气血和畅，脏腑平衡，血海充盈，经血才能调畅。

2.3.2 调补冲任通月水

陈自明如是表述：“冲为血海，任主胞胎……二脉流通，经血渐盈，应时而下。”他又提到：“经水枯竭，则无以滋养，其能行乎？”他的看法是，月经不顺畅源自冲任两脉的损害以及肾气不足，因此需着重调整冲任脉，补足肾气并增进精元与养血，从而濡养生命之源。故多用菟丝子、熟地黄、茯苓、续断、肉苁蓉等药以补肾益精、调理冲任，以治疗精血亏损所致的月水不通。

2.4 经典案例

医案：魏某，女，闭经两个月。自诉三月前因工作环境寒凉，经期开始推后，量少，颜色偏暗，有血块，经前伴有乳房胀痛，胸闷，腰酸，腹部怕冷，人疲倦乏力，汗出正常，素怕冷，喜温饮，咽中有堵塞感。偶有心慌心悸。食纳一般，食后易腹胀，有饱噎。舌淡胖边有齿痕，苔薄白，脉沉弦。方选逍遥散合温胆汤加减。柴胡 12g，当归 12g，白术 10g，白芍 12g，茯苓 10g，炙甘草 6g，法半夏 10g，陈皮 10g，枳实 6g，竹茹 10g，生姜 3 片，大枣 3 个，益母草 10g，厚朴 10g，桂枝 6g。7 剂，水煎服，日一剂。症状好转。

按语：患者因外感寒邪，造成气血凝结，经血运行不畅，疏泄失常，出现月经量少，色暗，有血块伴有腰酸，怕冷，导致闭经。肝郁气滞，故乳房胀痛，胸闷。治以疏肝通脉，和畅气血。方选逍遥散合温胆汤加减。柴胡疏肝解郁；当归、白芍养血柔肝；白术、茯苓健脾去湿；炙甘草补中益气；法半夏、竹茹化痰和胃，止呕除烦；陈皮理气行滞；枳实降气导滞；生姜、大枣调和脾胃。加益母草活血调经；厚朴理气消胀；桂枝、白芍温通经脉，温阳补虚。

3 痛经

痛经，特指女性在经期或经行前后所经历的周期性小腹疼痛，常伴随腰骶酸痛，甚至有时疼痛剧烈至晕厥，严重制约了女性的日常生活和工作效率。该病症亦被通俗地称为“经行腹痛”，凸显了这一临床常见病其独特的疼痛特征及对女性生活质量的极大影响。汉唐方书《华佗神方》首次提出“痛经”一词，将妇女月经来潮时，腹部绞痛，称为痛经。

古代医家在记载女性痛经问题上，首次发现于东汉时期张仲景所著的《金匮要略》：“带下，经水不利，少腹满痛，经一月再见者，土瓜根散主之”。揭示了血瘀阻塞导致经期不顺和下腹痛等症状的痛经发病原理，并提供了相应的治疗药方。陈自明在《妇人大全良方》一书中亦认为痛经的发生是“寒气客于血室”所致，认为寒凝、气滞、血瘀皆有关，均可导致痛经的发生。其后《傅青主女科》、《医宗金鉴》进一步论述了痛经的病因病机，补充了肝郁、寒湿、肾虚方面的病因病机^[59]。随着各代医家对痛经不断地加深认识，现把痛经的病机概括为“不荣则痛”或“不通则痛”。

3.1 病因

3.3.1 外感风寒湿邪

《诸病源候论》中提及：女性经期腹部疼痛，往往是劳劳累累伤了血和气，导致身体衰弱，外加寒冷气息侵袭子宫血络，伤及生命之脉。将感染寒风冷气视为引发痛经的主要外在因素。陈自明在其著作《妇人大全良方》里也有提到：“经血虚，则受风冷”。而《傅青主女科》亦提到：寒湿之邪充斥两经，引起内部紊乱，导致剧痛。对于女性月经即将到来时小腹先感疼痛的成因作了阐释。故妇人行经时若感外来风寒湿邪，以致经络冲任损伤，可发为痛经。

3.3.2 七情内伤

在《严氏济生方》“妇科门”篇章中，宋代医家严用和曾论述七种情绪，即“喜、怒、忧、思、悲、恐、惊者”可能引起妇女经期疼痛的观点。他提及“气一壅滞，则血与气并……或月事将行，预先作痛”，认为七情若是内阻，在女性中会导致血气淤滞更为严重，当气之流转受阻时，血流亦随之受阻，故有时月经即将来临时，痛感便会提前出现，确信女性的痛经症状往往与内心情绪的波动有关。张从正亦提出“忧思气郁而血滞”，认为情志内伤，特别是气郁可导致痛经。

3.2 病机

3.2.1 气血失和

《万氏妇人科》所述：“凡经水将行，腰胀腹痛者，此气滞血实也”。这阐述了月经疼痛的原因之一就是气血不畅。气与血是彼此依存的，血液顺畅地流动需要气的驱动。如果气的流转受阻，血液不能正常流通，便会导致血液瘀滞而引起经痛。在《陈素庵妇科补解》中也有记载：“妇人经行后腹痛者，是气血两虚也”。女子在月经结束后出现腹部疼痛，通常是因为气虚和血虚造成的。血与气，一阴一阳，相互维系，气虚则无法生血，血虚则无法养气，气血不足，故冲任、胞宫失于濡养，则发为痛经。

3.2.2 脏腑失调

3.2.2.1 肾

肾乃先天之本，元气之源泉，与女性月事、胞宫胞脉亦有紧密联系。如《傅青主女科》所述：“妇人少腹疼于行经之后者……人以为气血之虚也，谁知是肾气之涸乎”。指明女子若在经期后腹部疼痛，多因肾气枯竭。肾气亏虚，精血乏源，冲任失于濡养，血液生化之源不足，导致气虚血亏，使冲任、胞宫失荣，而发痛经。同时，肾阳虚衰使机体无力推动气血运行，流通受阻，导致痛经发生。

3.2.2.2 脾

脾为后天之本，气血生化之源。脾气不足，同样可能致使气血虚弱，无力推动血液运行，长时间累积便形成瘀血，影响经脉通畅，不通则痛，进而引起痛经。亦或由素禀脾虚所致，或平素喜好冷饮，更或经期产后不慎受寒，均可能损伤脾阳。当脾阳受损，其运化失职，则气血生化不足，胞宫失于濡养，不荣则痛引发痛经。故痛经的发生亦与脾阳不足相关。

3.2.2.3 肝

《傅青主女科》论述了妇女痛经与肝肾功能紊乱的联系，指出“盖肾水一虚，则水不能生木，而肝木必克脾土，土木相争，则气必逆，故尔作痛”，肾虚导致肾水不能滋养木，肝阴不足，木又克土，土木交战，气机受阻，终致痛经。同时傅青认为，若女性患有肝郁，即肝脏功能失去疏通作用，气机不畅而积聚化为内热，也能导致经痛。叶天士的见解是，如女性在经期将至时腹部剧痛并伴有食欲显著减退等征兆，通常是肝脏的调畅功能失常，导致经络中的气滞挫阻，肝气侵扰脾脏，致使脾脏运化失常，自然引发

进食动力不足等症状。

3.3 治疗经验

3.3.1 调气和血使经行顺畅

古代盱江医家多认为痛经之因多归咎于气血不和，相互冲突致痛，血气和顺则经行得以如期而顺畅。龚廷贤在《万病回春》中提出“调养气血”的治法。古代盱江医家在治疗女性痛经问题上，通常以四物汤作为治疗的基本方，如若女性在经期来临前就开始体验到痛感，大多数情况是由于气血流转不畅造成，为此配伍延胡索、莪术、红花等药帮助促进气血循环；如果女性在月经后期才出现痛感，这样的症状多与气血亏损有关，故此选择配伍人参、白术等益气养血。《古今医鉴》一书中，龚信有提及当女性月经将至，小腹忽然剧烈作痛，痛感迅速来去，在这种情况下，宜采用清热活血汤，此方包含当归、川芎、白芍、生地、黄连、香附、桃仁、红花、延胡索、丹皮、莪术，旨在清热活血，化瘀止痛。

气之作用在于生成与推动血液，因此气虚时既会导致生血不充分引起血虚，同时也会因为气弱无法有效推动血流，结果使血液流动迟缓而形成瘀血。故古代盱江医家在补血活血的同时会配伍理气药，如香附、陈皮等。危亦林选用当归、延胡索、蒲黄、赤芍药、官桂来诊治妇人因为七情内伤，导致血气相并心腹痛。

3.3.2 温经散寒以止痛

气血受阻且无法畅通即引发疼痛，为引起痛经的主要原因，而寒性属于阴邪，具有凝滞的特性，是引致血气不畅最常见的诱因。寒邪损害人体，使得气血经脉凝滞，出现阻塞便会引痛。《妇人大全良方》亦曾阐述“若经道不通，绕脐寒疝痛彻……此由寒气客于血室”，这是因为寒气侵入，造成血液凝结不流动，凝结的血块被新生的血气冲刺，旧新血液互相搏击，从而诱发疼痛。揭示了寒气从外部侵袭导致痛经的病理过程，并且推崇温经汤以及桂枝桃仁汤、万病丸等方剂作为散寒治痛经的代表方药。

3.4 经典案例

医案：李某，女，19岁，经行腹痛2年余。患者自诉2年前冬季月经期间受寒后开始出现腹痛症状，平素怕冷，月经偶有推迟，月经量较少，色淡，经行期间腹痛难忍，甚则卧床，面色痿白，四肢无力，发作时偶有头晕目眩。舌淡，苔白，脉细。治以温经散寒，补气养血。方用四物补经汤。当归、川芎、白芍、熟地黄各12g，香附12g，黄

芪 10g, 人参 8g, 白术 10g, 茯苓 10g, 阿胶 6g, 沉香 8g, 延胡索 10g, 陈皮 10g, 黄芩 10g, 砂仁 8g, 小茴香 8g, 吴茱萸 8g, 甘草 8g。7 剂, 水煎服, 日一剂。二诊症状好转, 兼服乌鸡丸调理, 后痊愈。

按语: 患者因寒邪凝滞, 导致血气不畅, 故经行腹痛。血液运行不畅, 以致血虚不能濡养机体, 故面色痿白。脾气虚弱, 舌淡苔白脉细, 故四肢无力, 头晕目眩。气与血相互依存, 血液顺畅流动需要气的驱动, 气虚则血虚, 故治以气血双补, 调和气血。方以四物汤为底, 当归、川芎、白芍、熟地黄补血养血; 阿胶养阴补血; 人参、黄芪大补元气; 香附、沉香、延胡索、陈皮、黄芩、砂仁行气理气; 茯苓、白术健脾益气; 吴茱萸、小茴香温里散寒; 甘草益气补中、调和众药。后兼服乌鸡丸补气养血、调经止带。

4 月经不调

月经不调是一种复杂的月经病, 泛指月经周期、经量、经色以及经质等方面的异常表现。具体来说, 月经不调涵盖了多种情况, 每一种都可能对女性的身体健康和生活质量产生不同程度的影响。其中包括月经周期异常的月经先期、月经后期、月经先后不定期, 还有以经量异常为主的月经过多、月经过少。

唐朝时期, 孙思邈在其著作《备急千金要方》中最初提出了“月经不调”一词, 对月经周期的不规律如周期延长缩短、月经提前或推迟以及闭经现象进行了记载, 并详细描述月经颜色异常、腰部剧痛、双腿酸楚以及子宫受寒等症状, 说明已将月经周期异常和经期异常归于月经不调的范围。宋代《圣济总录》又有“月水不调”、“月候不调”、“经候不调”、“经水不调”等关于月经不调的名称。明清时期基本沿袭前代月经不调的病名, 而随着对理论的深入研究, 月经不调的各个症状开始成为独立疾病^[60]。

4.1 病因

4.1.1 六淫侵袭

《万氏妇人科》曰: “一月再行兮, 邪火迫而气血不藏。”《傅青主女科》中提到: “先期而来多者, 火热而水有余也。”这句话阐述了因火邪过盛入侵人体, 内热搅乱冲任脉络, 迫使血液流动失常, 从而引起经期失衡。而《妇人大全良方》中摘录王子亨理论指出: “经者常候……过于阳则前期而来, 过于阴则后时而至。其有乍多乍少……亦由阴阳衰盛, 寒热为邪。盖阴气胜阳……故令乍少而在月后。若阳气胜阴……故令乍多而在月前。”《诸病源候论》又言: “……风邪冷热之气客于经络, 乍冷乍热……故令血

或多或少，乍在月前，乍在月后，故为不调也。”提出机体若外感寒邪，则血脉受寒而凝滞，血行不畅，导致血海蓄溢失常；若外感热邪，则热盛伤血，迫血妄行，亦使血海蓄溢失常，从而引发经行先后无定期的现象，导致月经不调。

4.1.2 内伤七情

《万氏妇人科》有曰：“女子之性，执拗偏急，忿怒妒忌，以伤肝气。”又言：“经过期后行，如性急躁，多怒多妒者，责其气逆血少也。”说明女子性情急躁易怒，往往导致气机紊乱，当肝气动血或肝火旺盛时，冲任的固摄功能可能受损，气血运行也变得异常。若肝气郁结，可能导致冲任之脉的阻滞；若肝气犯脾，也可导致冲任得不到充分滋养，血海空虚，最终引发月经不调。

《万氏妇人科》又谈及道：烦恼忧思便会损害心脏，心气遭受损害，而脾气也因此而得不到滋养，因此，脾胃力量不足，食欲减退，气逐日消耗，血亦逐渐减少，于是出现血液枯竭、血脉阻塞以及血色淡薄的情况，月经来潮推迟，或是数月才来一次的情形。内心忧虑愁苦，或长期思索考虑，劳伤心脾，血海过期不满；或思虑过度，耗伤心血，阴血不足，虚火妄动，迫经妄行；或情志不遂，心脾气结，致时而生化不足，时而统摄失常，致月经不调。

4.1.3 素体劳伤

《太平惠民和剂局方》曰：“劳伤血气，冲任虚损，月水过多。”如过度劳累伤身，将致使人体内的阳气不济，腠理也随之松懈，血气衰弱，造成体液无法留于体内，导致汗出过量。如果身体因虚弱而持续不断地出汗，将会导致呼吸急促，体形消瘦，以及体弱多病。此外，还有可能影响血液的正常循环，造成气血在经络中不能顺畅流动，严重时甚至可能引起经络堵塞。长期过劳或持续性疲劳对脾脏机能造成伤害，可能会使冲任功能紊乱，抑或因阴血不足或虚火上延而令经络功能紊乱，引起月经不调。

4.1.4 体质因素

《医学入门》记载道：“瘦人只是血少……肥人多痰”，及《万氏妇人科》载述“不及期而经先行……如形肥，多痰多郁者，责其血虚气热也”。说明平素身形瘦弱，常伴阴液不足，阴虚则易生内热；或脾胃虚弱，运化功能减退，则血海空虚，无法充盈滋养胞宫。平素形体肥胖，多因脾虚不运，痰湿内生，痰湿之邪壅滞冲任二脉；或痰湿进一步郁而化火，火热之邪迫血妄行。以上皆可导致月经不调。

4.2 病机

4.2.1 气血失调

4.2.1.1 气虚血热

《女科证治准绳》云：“经水过多为虚热，为气虚不能摄血。”阐述月事不调之关键病理在于气虚与血热。气虚则统摄无权，冲任不固，气统摄血液的功能失调，经血妄行，致月经先期。若热邪侵入血分，血热炽盛，便会扰乱冲任二脉，导致经血运行不定，致月经先期、月经过多；若热邪与血液相搏，炽热伤及津液，会导致阴液亏损，血液随之减少，血海不能正常充盈，导致月经后期、月经量少。

4.2.1.2 血虚

血虚而不归经也是月经不调的病机之一，李梴亦提及“后期三五日者为血虚”。脾气虚弱，则化源匮乏，血海因此空虚，导致经血无法按期而至。此外，若阴血不足，血海的蓄溢平衡受到影响，可能出现月经过多或过少的情况。同时，固摄之力减弱，血液难以归经，会进一步加剧月经不调。

4.2.1.3 气郁血滞

《万病回春》中提到：“经水过期而来，紫黑成块者，气郁血滞也。”指出气郁血滞也是月经不调的病机之一^[61]。血液瘀滞在冲任二脉，会使得月经量变少；或者是血液运行遇阻，新血不能按常规通道流淌，从而使管理失度，导致月经量异常增多。

4.2.2 脏腑冲任失调

《傅青主女科》一书记载：“有先期经来只一、二点者，人以为血热之极也，谁知肾中火旺而阴水亏乎！”肾阴亏虚，若阴不制阳，则虚火内生，扰动冲任与血海，致使经血失其常道，妄行而出，常致月经先期、月经过多；阴虚火旺，可致血燥经少，血海不能如期充盈，从而引发月经后期、月经过少。《傅青主女科》亦载：“妇人经来断续，或前或后无定期，人以为气血之虚也，谁知是肝气之郁结乎！”说明若情志郁闷不畅，肝功能失调，从而引发气血流转不畅，这样的阻滞不光会影响冲任二脉的流畅，还可能因气血不顺而导致经期血量减少、周期延迟；亦或由于气机失调，冲任二脉失去和谐运作，血海蓄溢失常，导致经期缺乏一定的周期性。《女科精要》中阐明，女性若患月经失序，可能是由于外界寒风侵袭了体内的虚弱部位，损害了冲任二脉。这两条脉络起于胞中，若能运行顺畅那么血气自然能和谐流通，不会受到六淫的侵害。如果因过劳导致

气血受损，被寒风侵袭后，脾胃功能亦会受到影响，饮食量逐渐减少，出现肌肉消瘦和面色苍黄的现象，这些症状都是因为冲任二脉受损。冲为血海，任主胞胎，两者一旦气流通不畅，其功能出现失衡，月经不调便是必然的结果。

4.2.3 痰阻血海

《丹溪治法心要》有言“经水过期，淡色者，痰多也”，又言“痰多占住血海地位，因而下多”。说明痰湿阻滞冲任，有碍血海满盈，致月经不调。

4.3 治疗经验

4.3.1 寒温得当，辨病下药

血热多致月经先期及月经过多，血虚有寒多致月经后期及月经过少，故用药需辨寒温，用药性寒凉具有清除血分热邪作用的方药治疗血热；用具有温阳散寒、滋阴养血作用的方药治疗血虚有寒。如《医学入门》记载“先期来多血有余”，由于血热导致月经先期者，治疗常用四物汤加黄芩、黄连，若体型偏胖则加祛痰药；“来多或日多五六日以上者，内热血散也”，用四物汤加黄芩、白术；而“后期来少血不足”者，四物汤加人参、黄芪、白术、陈皮、升麻；若“或前或后气血乱”，方选当归散、调经散、单丹参散。

4.3.2 开郁行气，养血调经

《妇人大全良方》曰：“然妇人以血为基本，气血宣行，其神自清。”《万病回春》又言治疗月经不调应“治当调经顺气，经自准也”。妇人以血为本，但血脉运行通畅要依赖于气，血随气行，气不调则血脉不顺，气郁血滞，瘀阻经络，则月经失调^[62]。故妇人养血调经应当以开郁行气为先导，治血必治气，治以开郁行气为主，郁开气行，而月经自调。

4.4 经典案例

医案：赵某，女，月经不规律6年余。自诉6年前出现月经推后，最长可达两月。月经量少，色暗，有血块。腹部怕冷，经前乳房胀痛，小腹坠胀感。人疲倦乏力，头痛头昏。白带色黄，呈浓稠状，味臭。身有潮热，腰酸脚软。舌淡暗，苔白，脉沉紧。治以温经散寒，养血祛瘀。方选温经汤。当归10克、白芍10克、桂枝10克、吴茱萸3克、川芎6克、干姜6克、法半夏10克、牡丹皮10克、麦冬6克、人参10克、炙甘草6克、阿胶5克。7剂，水煎服，日一剂。症状好转。

按语：患者因冲任虚寒，血凝气滞，导致血海不能按时满盈，故月经不调，周期延后。寒凝冲任，故经色暗，有血块，腹部怕冷。寒邪阻滞气血，故乳房胀痛。阳虚肾气不足，故人疲倦乏力，腰酸脚软。舌淡暗，苔白，脉沉紧皆为寒象。方中吴茱萸、桂枝温经散寒，通利血脉；当归、川芎、阿胶、白芍合用活血祛瘀，养血调经；牡丹皮活血散瘀；麦冬、半夏、生姜调经润燥；人参、甘草益气健脾，补气和缓。

不足与展望

本课题通过查找收集古代盱江医家的医案进行数据挖掘,分析其治疗月经病的经验及用药规律,总结其学术思想。然而仍有一些不足之处:首先,古代盱江医家著作成册的数量相对较少,还有很多零散的医案难以找寻,以及现存古籍的数量不多,导致最后整理纳入数据库的医案数量不多,涵盖范围略不全面。其次,笔者的中医理论水平及临证思维能力有限,对月经病的理论框架及临证经验的研究可能不够全面。故今后会多研读古籍,加强自身中医理论,尽力提升自己的科研素养。

结 论

1. 古代盱江医家用药以血药为主，气药为辅，以四物汤及八珍散的药组为核心处方进行加减，体现了其治疗月经病时以补血养血为主要治法。常用药物有：当归、川芎、白芍、甘草、香附、肉桂、熟地黄、白术、生地黄、茯苓；常见药物关联有：当归-川芎-白芍、当归-甘草、当归-香附；常见药物聚类组合有：“当归、川芎、白芍、香附”、“甘草、熟地黄、陈皮、柴胡、白术、茯苓”、“肉桂、干姜、牡丹皮、延胡索、吴茱萸、人参、黄芪”、“生地黄、黄芩、赤石脂、地榆、阿胶、艾叶”、“红花、桃仁、蒲黄、莪术、赤芍、白芷、牛膝”。

2. 月经病多由外感寒热湿邪、内伤七情、劳逸失调、先后天体质因素等导致气血失和、脏腑受损、冲任失调，且发病症状多与血相关，而参与血液生成及运行多涉及肝、脾、肾三脏，故古代盱江医家治疗月经病以调和气血为主，气机调畅则血液正常运行，血液充足则滋养气的生成，气血旺盛则脏腑、冲任功能正常，血海充盈，月经正常。同时月经病疾病症状复杂，要重视辨病辨证，对症下药。

参考文献

- [1] 谢强, 周思平. 盱江医家医籍及地域分布略考[J]. 江西中医药, 2013, 44(03): 3-7.
- [2] 王静, 夏桂成. 国医大师夏桂成教授月经周期分期分时法探析[J]. 江苏中医药, 2022, 54(08): 24-27.
- [3] 詹金玉, 高月平, 束长珍. 高月平运用保阴煎治疗阴虚血热型月经病血证经验[J]. 湖北中医杂志, 2023, 45(12): 12-16.
- [4] 布外散·阿不都热合曼, 辛效毅. 辛效毅教授治疗月经不调经验[J]. 新疆中医药, 2022, 40(04): 40-42.
- [5] 张瑾, 徐传花. 孟河医派费氏治疗月经病组方用药规律探索[J]. 光明中医, 2023, 38(24): 4711-4714.
- [6] 蔺倩琪, 高林, 李佳锦等. 云南姚氏妇科论治月经病“首重肝脾冲任”学术思想探析[J]. 中国民族民间医药, 2022, 31(09): 5-7.
- [7] 郑立宏, 常胜, 常青. 常青治疗月经病经验撷菁[J]. 浙江中医杂志, 2023, 58(09): 641-642.
- [8] 方晶晶, 马姣晖. 温通法治月经病体会[J]. 浙江中医杂志, 2023, 58(12): 923-924.
- [9] 陈维爱, 刘晓燕. 中药分期治疗放环后月经不调的临床观察[J]. 河南中医学院学报, 2009, 24(04): 90-91.
- [10] 陆永辉, 张汝菁, 王克键等. 阎润茗针灸治疗月经病经验[J]. 河北中医, 2014, 36(12): 1769-1770.
- [11] 韩丽凤, 米勇. 徐占英针灸治疗月经病的辨证思想及临证经验[J]. 新疆中医药, 2013, 31(06): 37-38.
- [12] 何冠衡, 邬志雄, 王倩. 王倩教授针灸周期疗法治疗月经病经验介绍[J]. 新中医, 2012, 44(04): 153-155.
- [13] 林福平, 彭锦荣. 子宫腺肌症导致痛经患者实施中医穴位敷贴结合个性化护理对月经周期的调节作用[J]. 黑龙江中医药, 2023, 52(02): 279-281.
- [14] 李趣英. 温胞饮联合穴位埋线治疗肾虚血瘀型子宫内膜异位症痛经临床观察[J]. 中国中医药现代远程教育, 2023, 21(20): 91-93.
- [15] 陈文潇, 江苗. 四逆汤加味联合中药热奄包治疗寒凝血瘀型痛经的疗效及对前列腺素水平的影响[J]. 临床合理用药, 2023, 16(33): 97-100.
- [16] 胡盛书, 车丽娟, 傅娇等. 基于 Wnt/ β -连环蛋白信号通路探讨少腹逐瘀汤治疗寒凝血瘀型子宫内膜异位症痛经的疗效及其机制[J]. 现代生物医学进展, 2023, 23(22): 4325-4328+4240.
- [17] 谢海燕. 少腹逐瘀汤联合米非司酮治疗子宫腺肌病伴痛经寒凝血瘀型疗效观察[J]. 实用中医药杂志, 2024, 40(02): 316-318.
- [18] 曾美英. 加味当归芍药散辅治阴虚血热型月经失调的疗效及对性激素、月经周期的影响[J]. 临床合理用药, 2023, 16(35): 114-117.
- [19] 莫满芳, 赵敏, 林文静等. 逍遥散中药配方颗粒与传统中药饮片治疗肝郁脾虚型月经失调的疗效差异研究[J]. 亚太传统医药, 2023, 19(11): 107-111.
- [20] 唐圆圆. 加味逍遥散结合激素周期疗法对肝郁血虚型月经失调患者的疗效评价[J]. 大医生, 2023, 8(20): 107-109.
- [21] 赵丽, 康幼雯, 李雅丹. 当归芍药散配合布洛芬治疗原发性痛经的疗效及对血清疼痛介质和子宫动脉血流动力学的影响[J]. 中国药物与临床, 2023, 23(02): 109-113.
- [22] 何晓晖, 陈明人, 简晖, 等. 盱江医学研究[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2018.

- [23]杨卓寅. 江西杏林人物[M]. 南昌:江西省卫生厅, 1988.
- [24]谢强, 周思平, 黄冰林. 盱江流域及盱江医学地域分布今考[J]. 江西中医学院学报, 2012, 24(06):11-14.
- [25]谢强, 周思平. 盱江医家医籍及地域分布略考(续一)[J]. 江西中医药, 2013, 44(04):3-8.
- [26]冯晓玲, 张婷婷. 中医妇科学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2021.
- [27]刘敏如, 欧阳惠卿. 《实用中医妇科学》[M]. 上海科学技术出版社, 2010.
- [28]姚乃礼. 中医症状鉴别诊断学[M]. 人民卫生出版社, 2000.
- [29]中华人民共和国药典:2020 年版[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2020.
- [30]中华本草[M]. 上海:上海科学技术出版社[M], 1999.
- [31]高学敏. 中药学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2017.
- [32]郭晓香. 浅析中药当归的炮制及应用与药理初探[J]. 世界最新医学信息文摘, 2017, 30(17):175-176.
- [33]李梅, 杨梅, 赵琦等. 当归的临床运用及用量研究[J]. 贵州中医药大学学报, 2023, 45(06):32-36.
- [34]王永忠, 童树洪. 川芎的传统用法与现代药理研究[J]. 中国药业, 2012, 21(07):95-96.
- [35]吴玲芳, 王晓晴, 陈香茗等. 白芍化学成分及药理作用研究进展[J]. 国际药学研究杂志, 2020, 47(03):175-187.
- [36]韩莹, 张岩, 等. 基于当归/白芍提取物调节原发性痛经大鼠子宫供血的机制研究[J]. 中南药学, 2018, 16(5):625- 628.
- [37]李泽宇, 郝二伟, 李卉等. 甘草配伍应用的药理作用及机制分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(14):270-282.
- [38]肖先, 李春燕, 刘晓龙等. 甘草的主要化学成分及药理作用研究进展[J]. 新乡医学院学报, 2023, 40(03):280-285.
- [39]徐秀梅, 刘文建. 香附药理作用及临床应用的进展[J]. 广东化工, 2023, 50(09):122-123+69.
- [40]林红强, 周柏松, 谭静等. 肉桂的化学成分、药理活性及临床应用研究进展[J]. 特产研究, 2018, 40(02):65-69.
- [41]陈旭, 刘畅, 马宁辉等. 肉桂的化学成分、药理作用及综合应用研究进展[J]. 中国药房, 2018, 29(18):2581-2584.
- [42]凌福正, 黄小鸥. 无糖型地黄纤体颗粒的制备工艺及其质量研究[J]. 黑龙江医药科学, 2016, 39(1):67, 68, 71
- [43]刘棣文, 何莉莉, 崔娜等. 白术化学成分、药理作用研究进展及质量标志物预测[J]. 中医药信息, 2024, 41(01):65-78.
- [44]邓娟, 付萍. 2. 白术药对在中医妇科临床的应用举隅[J]. 辽宁中医药大学学报, 2008(01):122-123.
- [45]王朴. 生地黄的现代药理研究与临床应用[J]. 中国中医药现代远程教育, 2008(08):986.
- [46]马艳春, 范楚晨, 冯天甜等. 茯苓的化学成分和药理作用研究进展[J]. 中医药学报, 2021, 49(12):108-111.
- [47]张露, 吴小平, 史胜楠, 等. 痰饮病人“温药和之”与冠心病临证辨析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2022, 20(20):3819-3821.
- [48]张静雅, 曹煌, 龚苏晓, 等. 中药咸味药性表达及在临证 配伍中的应用 [J]. 中草药, 2016, 47(16):2797-2802.
- [49]杭传珍. 五味的药性特征及配伍应用[J]. 湖南中医药导报, 2001(03):134-135.

- [50]王思滕, 宫洪涛. 从肝脾生理病理关系浅论肝脾同治的运用[J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16(A2):152-153.
- [51]周红. 中医妇科常用药物归经分析[J]. 中国处方药, 2018, 16(06):102-103.
- [52]张莹莹, 张科, 宋崑等. “川芎-当归”药对主要活性成分的网络药理学研究[J]. 安徽医药, 2023, 27(01):19-24.
- [53]朱敏, 段金廛, 唐于平等. 当归-白芍配伍在痛经模型大鼠体内代谢产物的研究[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(09):4098-4103.
- [54]高素心. 当归芍药甘草汤治疗月经病的体会[J]. 黑龙江中医药, 1991(03):28-29.
- [55]商婷婷, 周俊兵, 任青玲. 陈自明辨治月经病经验采撷[J]. 中国中医药图书情报杂志, 2024, 48(01):201-203.
- [56]张颖, 庞玉琴, 王慧霞. 庞玉琴从热、虚、瘀论治崩漏经验[J]. 中医学报, 2023, 38(01):94-99.
- [57]杨云松, 卢威. 浅谈万密斋论治月经病的特色[J]. 时珍国医国药, 2023, 34(05):1186-1187.
- [58]彭佳华, 宋鑫, 梁瑞宁等. 盱江名医危亦林《世医得效方》妇科辨治特色探微[J]. 江西中医药, 2023, 54(07):1-3.
- [59]许栋涵, 罗业浩, 方刚等. 痛经病因病机古文献研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2023, 25(04):77-80.
- [60]李柳骥, 张聪, 侯中伟等. 月经不调类疾病病名及病因病机源流的述要[J]. 贵阳中医学院学报, 2011, 33(05):21-24.
- [61]徐若艺, 周玉杰, 叶斌. 盱江医著《万病回春》月经病诊治思路探析[J]. 中医药临床杂志, 2022, 34(03):441-443.
- [62]杜河洪, 李丛. 盱江医家龚廷贤陈自明月经病证治异同辨析[J]. 江西中医药, 2012, 43(10):7-8.